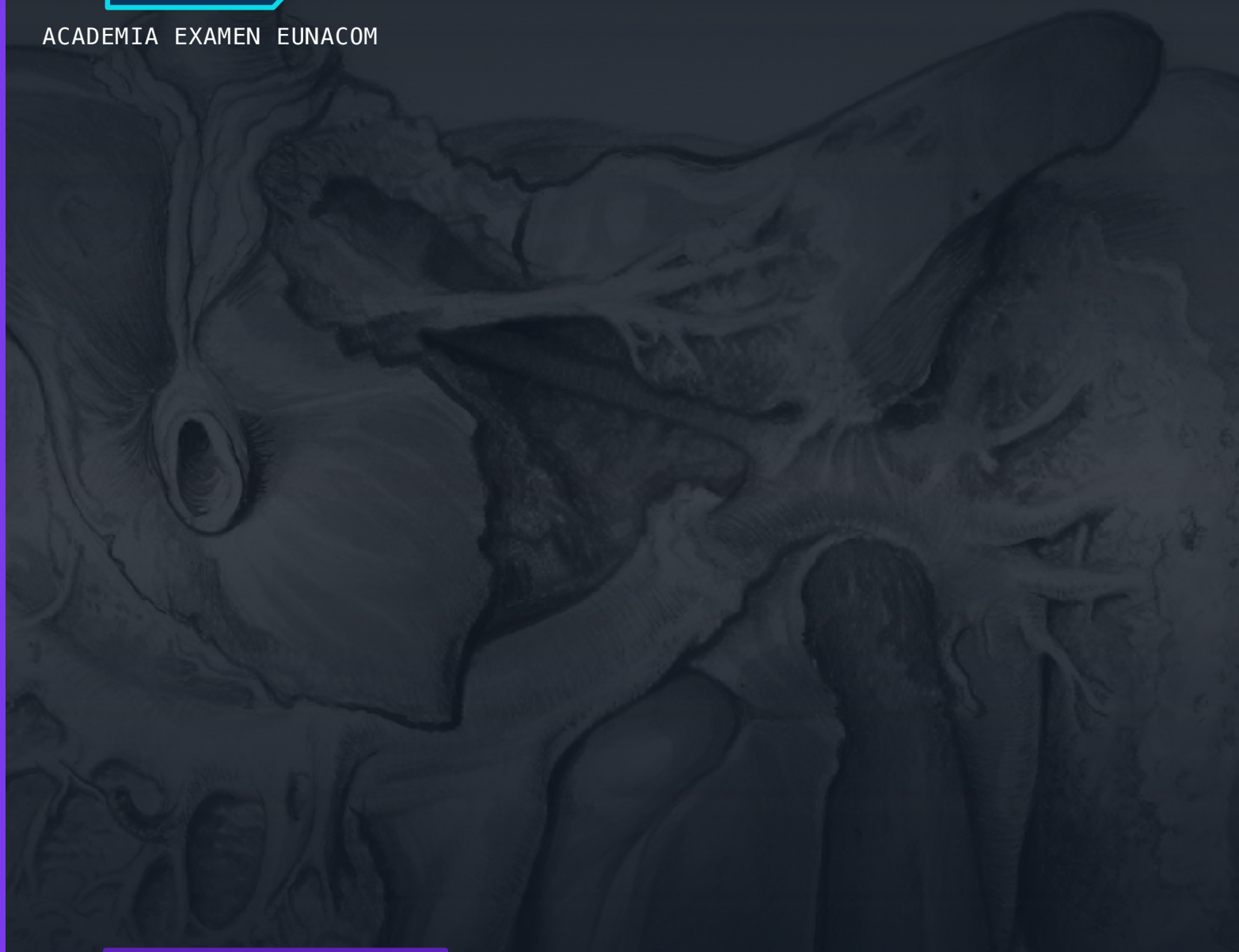
AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 07 · EM · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

ENDOCRINOLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

56	22	4
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 07

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 07 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 32

Índice por tipo de imagen 35

Soluciones de la autoevaluación 37

Signos con nombre propio 34

Autoevaluación 36

01 Patología Tiroidea Funcional: Hipotiroidismo y Tiroiditis

1.2 Hipotiroidismo Primario y Subclínico

01 Clínica del hipotiroidismo 4

02 Facies hipotiroidea 4

1.3 Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

03 Coma mixedematoso 5

1.4 Hipotiroidismo en Situaciones Especiales

04 Hipotiroidismo congénito sin tratar 5

05 El mismo niño con tratamiento 6

1.5 Tiroiditis

06 Tiroiditis: cintigrama en blanco 6

07 Patrones del cintigrama tiroideo 7

08 Ecografía de Hashimoto 7

09 Tirotoxicosis por amiodarona tipo 1: Doppler hipervascular 8

02 Bloque 2 · Tirotoxicosis, Bocio, Nódulo y Cáncer de Tiroides

7.6 Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

10 Bocio difuso de Graves 8

11 Eco Doppler de Graves 9

12 Orbitopatía tiroidea: retracción palpebral 9

13 Orbitopatía tiroidea en la TC coronal 10

7.7 Manejo Terapéutico Comparado

14 Graves: captación difusa 10

15 Adenoma tóxico 11

16 Bocio multinodular tóxico 11

17 Bocio gigante compresivo 12

7.9 Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

18 Gammagrafía: nódulo caliente 12

19 Nódulo TI-RADS 5 13

20 Nódulo con criterios de malignidad 13

21 Bocio multinodular 14

7.10 Cáncer de Tiroides

22 Carcinoma papilar 14

03 Bloque 3 · Corteza y Médula Suprarrenal: Cushing, Addison, Conn y Feocromocitoma

7.11 Síndrome de Cushing

23 Facies de luna llena 15

24 Fenotipo cushingoide 15

25 Equimosis por fragilidad capilar 16

26 TAC suprarrenal en el Cushing 16

7.12 Insuficiencia Suprarrenal Crónica

27 Enfermedad de Addison: hiperpigmentación 17

28 Addison: pliegues palmares 17

7.13 Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

29 Púrpura fulminante (Waterhouse-Friderichsen) 18

30 Necrosis distal en la sepsis 18

7.14 Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria

31 Adenoma suprarrenal en la RM 19

7.15 Feocromocitoma y Paragangliomas

32 Feocromocitoma en la RM 19

33 Gammagrafía con MIBG 20

34 Incidentaloma suprarrenal en la TAC 20

04 Bloque 4 · Metabolismo Mineral, Calcio, Paratiroides y Hueso

Índice por tema · continuación

7.16 Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico
35 Osteítis fibrosa quística 21
36 El QT y el calcio 21
37 ECG de hipercalcemia 22
38 Gammagrafía con sestamibi 22

7.17 Hipocalcemia Aguda y Crónica
39 Signo de Chvostek 23
40 Signo de Trousseau 23

7.18 Osteoporosis
41 Densitometría: cómo leer el T-score 24
42 Fractura de Colles 24
43 Fractura del cuello del fémur 25
44 Osteonecrosis mandibular por bifosfonatos 25
45 Fractura atípica subtrocantérea 26

7.19 Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo
46 Rosario raquítico 26
47 Muñecas ensanchadas en el raquitismo 27
48 Línea de Looser-Milkman 27

05 Bloque 5 · Hipófisis, Hipotálamo, Neuroendocrinología y MEN

7.20 Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria
49 Macroadenoma hipofisario en la RM 28
50 Craneofaringioma supraselar 28
51 Anatomía de la región selar 29

7.22 Acromegalia y Gigantismo
52 Fenotipo acromegálico 29

7.23 Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo
53 Silla turca vacía 30

7.24 Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)
54 MEN 2A: feocromocitoma 30
55 MEN 2B: neuromas mucosos 31

7.25 Ginecomastia
56 Ginecomastia bilateral 31

01 TEMA 1.2 · HIPOTIROIDISMO PRIMARIO Y SUBCLÍNICO

ESQUEMA

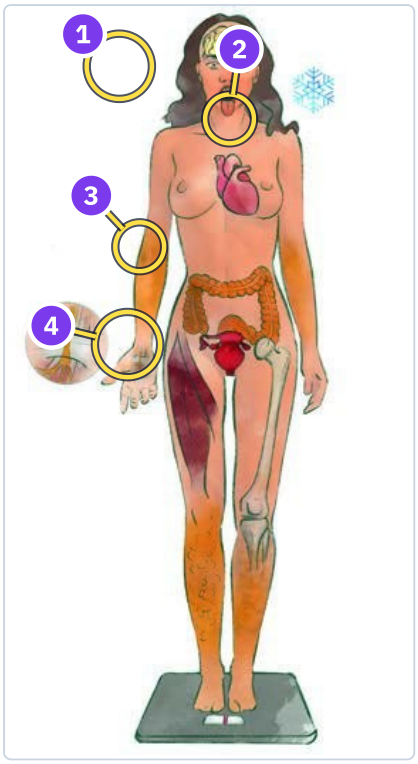


Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 55

QUÉ TIENES QUE VER

1. Bradipsiquia y somnolencia
2. Intolerancia al frío
3. Bradicardia
4. Constipación

DIAGNÓSTICO

Clínica del hipotiroidismo

Todo el metabolismo se enlentece: frío, corazón lento, intestino perezoso, piel seca.

CONDUCTA INICIAL

TSH alta con T4L baja: levotiroxina 1,6 µg/kg/día; en ancianos o cardiópatas partir con 25–50 µg.

1.03.1.002	Hipotiroidismo

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Depresión: ánimo bajo con TSH normal.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P36 «Un paciente se realiza una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspende el tratamiento con levotiroxina hace 6…» → **Piel seca**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 9
Tema 1.2

Clase 1.2 en video

02 TEMA 1.2 · HIPOTIROIDISMO PRIMARIO Y SUBCLÍNICO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., Fig. 152-12

QUÉ TIENES QUE VER

1. Edema periorbitario duro
2. Piel seca y pálida

DIAGNÓSTICO

Facies hipotiroidea

Cara abotagada con edema periorbitario duro que no deja fóvea: mixedema.

CONDUCTA INICIAL

Causa más frecuente: Hashimoto (anti-TPO positivo). Levotiroxina en ayunas.

1.03.1.002	Hipotiroidismo

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.03.4.005	Anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antiiroperoxidasa)

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Síndrome nefrótico: edema blando que deja fóvea.

PREGUNTA REAL

Agosto 2021 · P15 «Una paciente de 27 años, en amenorrea por lactancia, presenta un cuadro de astenia y malestar general, constipación y dificultades para…» → **Iniciar tratamiento con levotiroxina oral**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 9
Tema 1.2

Clase 1.2 en video

03 TEMA 1.3 · COMA MIXEDEMATOSO Y URGENCIAS HIPOTIROIDEAS

FOTO CLÍNICA

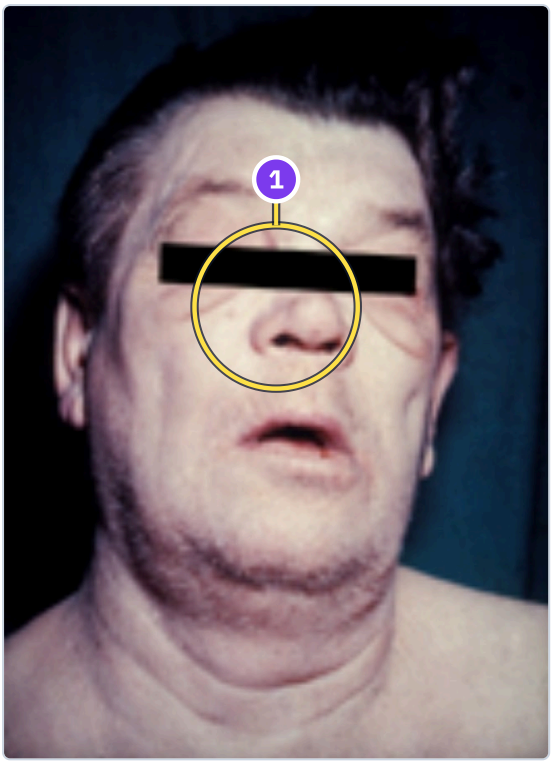


Imagen: Wikimedia Commons «Myxedema face.png», CC BY 2.5, Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk

QUÉ TIENES QUE VER

1. Facies infiltrada, apática

DIAGNÓSTICO

Coma mixedematoso

Cara infiltrada y apática en una mujer mayor, típicamente en invierno.

CONDUCTA INICIAL

UCI: hidrocortisona EV antes de la levotiroxina EV, calentamiento pasivo y soporte.

1.03.2.002 Mixedema — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipotermia ambiental o sepsis: buscar TSH.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P153** «Paciente con piel seca, bradicardia, hipotensión, compromiso de conciencia, TSH 100 y T4 libre muy baja. ¿Diagnóstico?» → **Coma mixedematoso**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 14** Tema 1.3

Clase 1.3 en video

04 TEMA 1.4 · HIPOTIROIDISMO EN SITUACIONES ESPECIALES

FOTO CLÍNICA

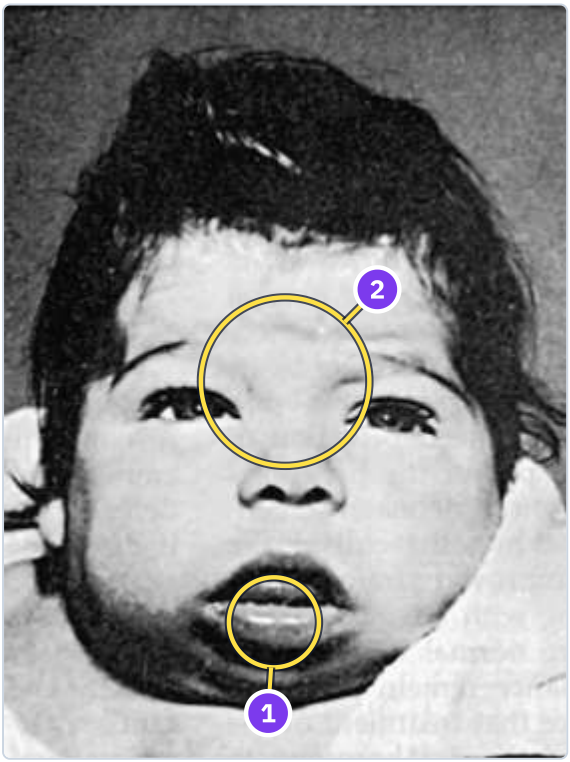


Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 4372

QUÉ TIENES QUE VER

1. Macroglosia
2. Facies tosca

DIAGNÓSTICO

Hipotiroidismo congénito sin tratar

Lactante de 6 meses: lengua grande, facies tosca, piel infiltrada.

CONDUCTA INICIAL

Tamizaje neonatal con TSH; levotiroxina antes de los 15 días para evitar el daño cerebral.

2.01.1.075 Hipotiroidismo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Síndrome de Down: también macroglosia, con pliegues palpebrales.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P53** «Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09…» → **Disminuir la dosis de levotiroxina**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 18** Tema 1.4

Clase 1.4 en video

05 TEMA 1.4 · HIPOTIROIDISMO EN SITUACIONES ESPECIALES

FOTO CLÍNICA

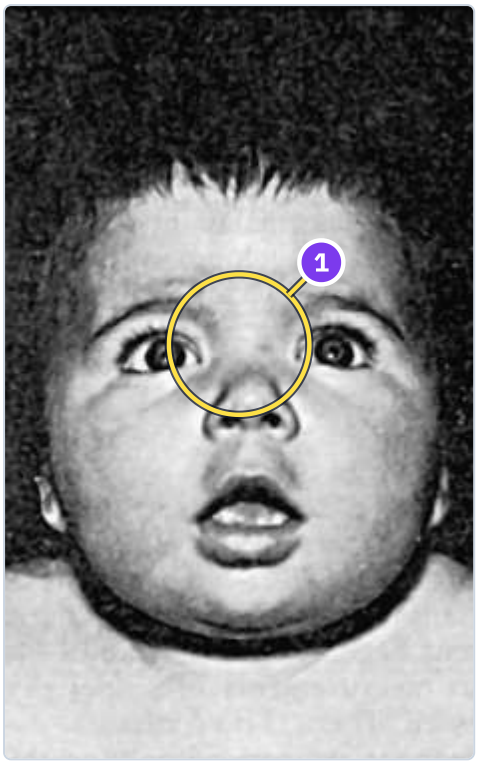


Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 4372

QUÉ TIENES QUE VER

1 Facies normal

DIAGNÓSTICO

El mismo niño con tratamiento

Desaparecen la macroglosia y la infiltración.

CONDUCTA INICIAL

Control de TSH y T4L; ajustar la dosis según peso.

2.01.1.075 **Hipotiroidismo**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Los signos clásicos aparecen tarde: el diagnóstico es por tamizaje.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P53 «Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09…» → **Disminuir la dosis de levotiroxina**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 18
Tema 1.4

Clase 1.4 en video

06 TEMA 1.5 · TIROIDITIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

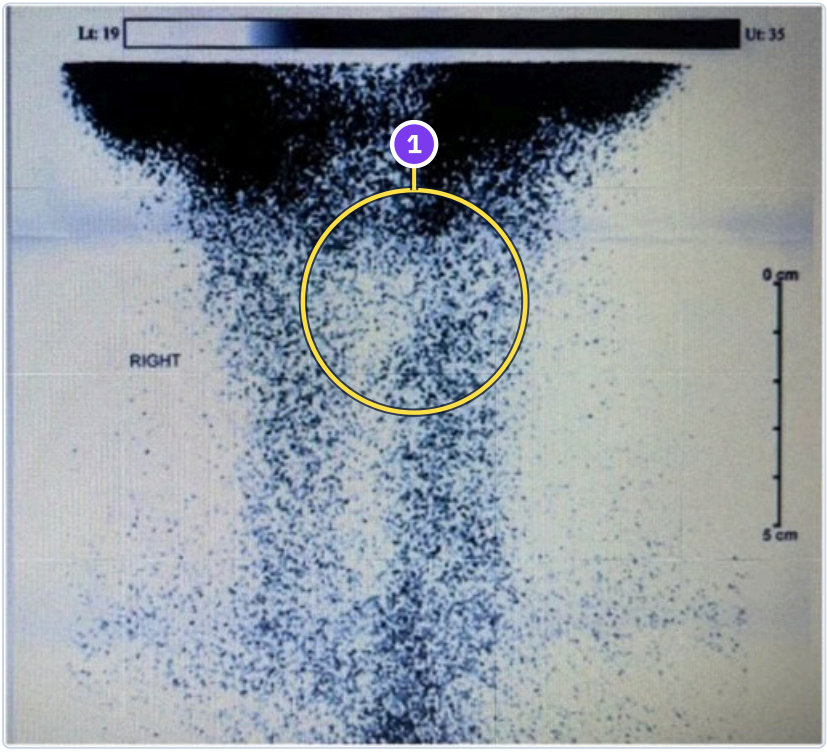


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sin captación en el cuello

DIAGNÓSTICO

Tiroiditis: cintigrama en blanco

La glándula ni se ve: captación casi nula, menor al 1–2%.

CONDUCTA INICIAL

De Quervain: AINE; propranolol si hay síntomas. No dar antitiroideos.

1.03.1.005 **Tiroiditis**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Graves: captación difusa y aumentada.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P30 «Una paciente de 23 años, consulta por malestar general y sensación febril de una semana de evolución, asociado a artralgias y palpitaciones. Al…» → **AINEs**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 21
Tema 1.5

Clase 1.5 en video

07 TEMA 1.5 · TIROIDITIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

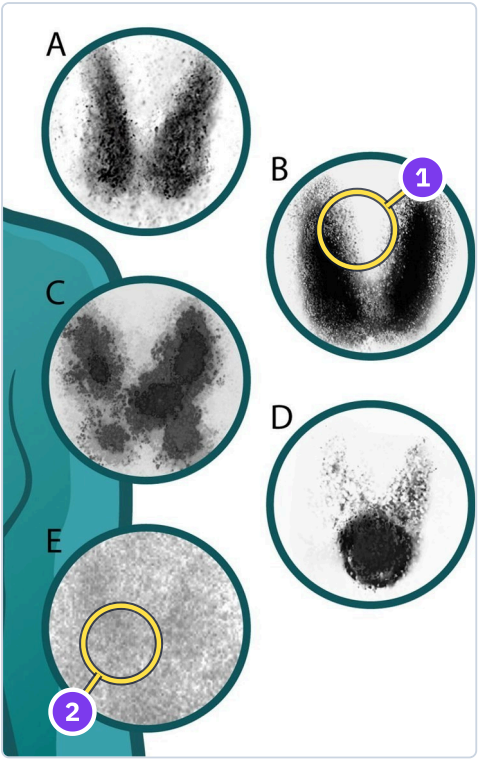


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. B: Graves, captación difusa
2. E: tiroiditis, en blanco

DIAGNÓSTICO

Patrones del cintigrama tiroideo

Normal, Graves difuso, bocio multinodular, nódulo caliente y glándula en blanco.

CONDUCTA INICIAL

El cintigrama separa hipertiroidismo verdadero (capta) de tiroiditis (no capta).

`1.03.1.005` **Tiroiditis**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

`1.03.1.003` **Hipertiroidismo**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nódulo caliente: un foco que apaga el resto.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P10 «Una paciente de 33 años, consulta por dolor cervical intenso de una semana de evo- lución asociado a sensación febril. Al examen físico destaca...» → **Ibuprofeno**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 21
Tema 1.5

Clase 1.5 en video

08 TEMA 1.5 · TIROIDITIS

ECOGRAFÍA

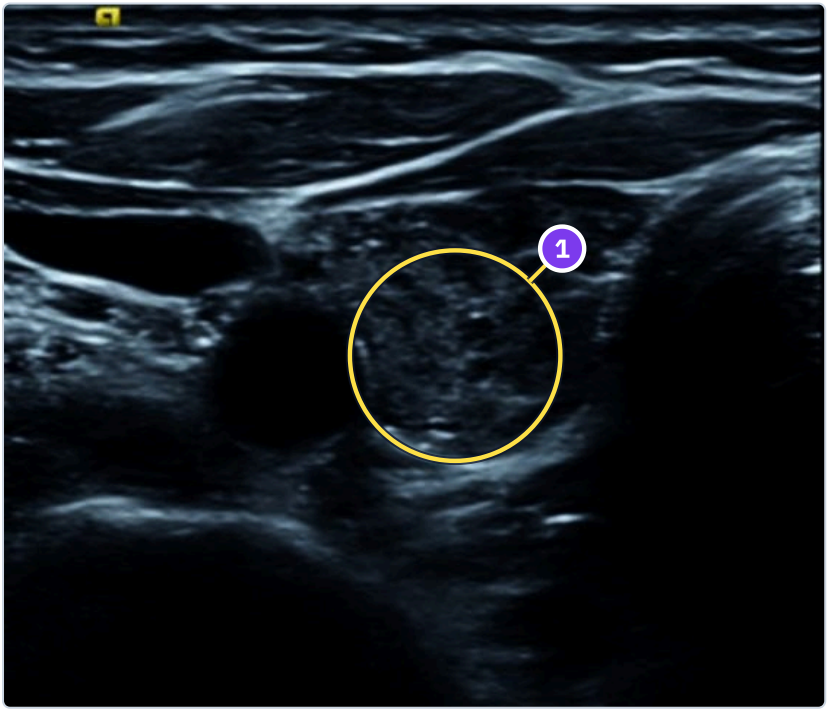


Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 55

QUÉ TIENES QUE VER

1. Parénquima heterogéneo e hipoecoico

DIAGNÓSTICO

Ecografía de Hashimoto

Tiroides heterogénea y globalmente hipoecoica, con tractos fibrosos.

CONDUCTA INICIAL

Anti-TPO positivo; tratar si hay hipotiroidismo.

`1.03.1.005` **Tiroiditis**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

`1.03.4.005` **Anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antiiroperoxidasa)**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Graves: también hipoecoica, pero muy vascular al Doppler.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 21
Tema 1.5

Clase 1.5 en video

09 TEMA 1.5 · TIROIDITIS

ECOGRAFÍA

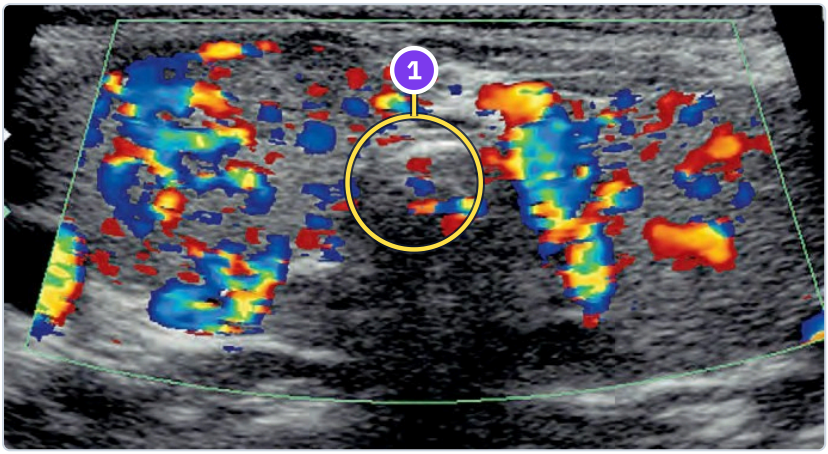


Imagen: Diagnostic Ultrasound (Rumack), p. 1725

QUÉ TIENES QUE VER

1 Glándula llena de color

DIAGNÓSTICO

Tirotoxicosis por amiodarona tipo 1: Doppler hipervascular

Flujo aumentado en toda la glándula.

CONDUCTA INICIAL

Tipo 1 (exceso de yodo, glándula vascular): tionamidas. Tipo 2 (tiroiditis, sin flujo): corticoides.

`1.03.1.005` **Tiroiditis**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

`1.03.1.003` **Hipertiroidismo**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tipo 2: glándula sin flujo al Doppler.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P149** «Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 36 semanas, con feto creciendo en percentil 6 en la semana 35, con Doppler materno fetal normal en…» → **Continuar el control semanal con…**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 21
Tema 1.5

Clase 1.5 en video

10 TEMA 7.6 · ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW Y SÍNDROMES TIROTÓXICOS

FOTO CLÍNICA

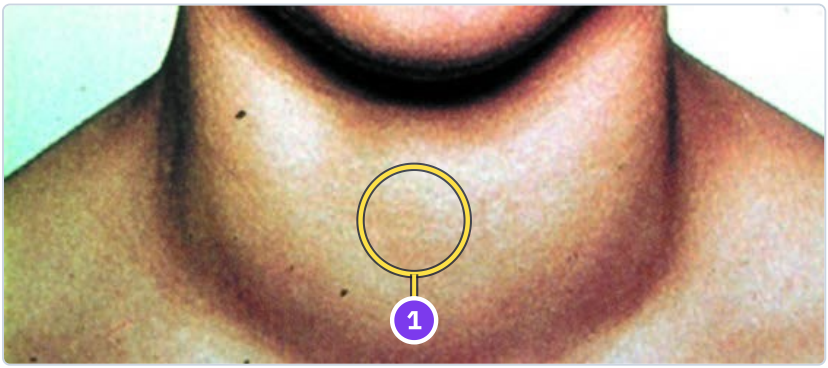


Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 57

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bocio difuso

DIAGNÓSTICO

Bocio difuso de Graves

La glándula entera crece de forma difusa y elástica.

CONDUCTA INICIAL

TSH suprimida, T4L alta y TRAb positivos.

`1.03.1.003` **Hipertiroidismo**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Bocio multinodular: nódulos palpables y asimétricos.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P149** «Mujer de 35 años con exoftalmo bilateral, palpitaciones, pérdida de peso y temblor fino en manos. TSH suprimida, T4 libre elevada. Bocio difuso….» → **Enfermedad de Graves-Basedow**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 27
Tema 7.6

Clase 7.6 en video

11 TEMA 7.6 · ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW Y SÍNDROMES TIROTÓXICOS

ECOGRAFÍA

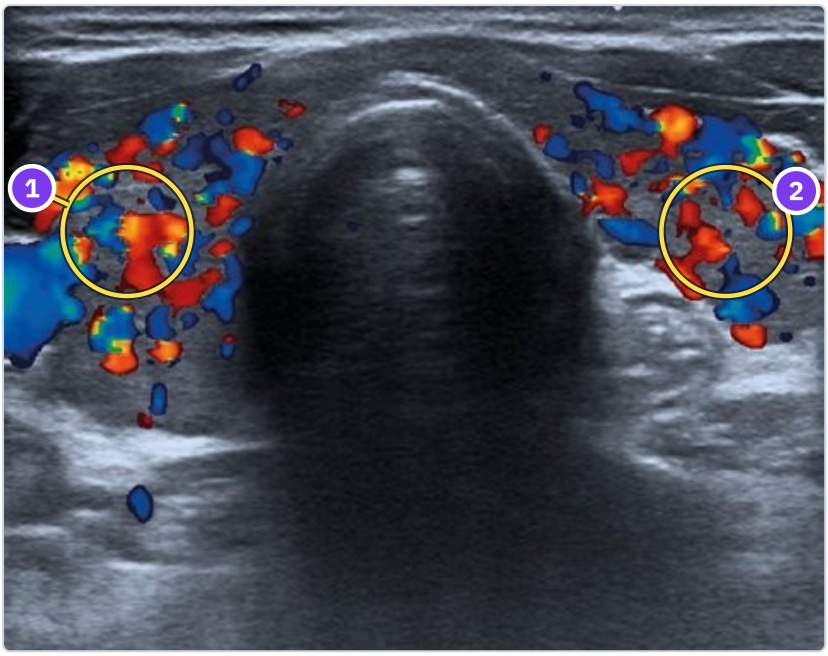


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 38

QUÉ TIENES QUE VER

1. Flujo aumentado
2. Flujo aumentado

DIAGNÓSTICO

Eco Doppler de Graves

Hipervascularización difusa: el "infierno tiroideo".

CONDUCTA INICIAL

Confirma Graves si no hay cintigrama.

1.03.1.003 Hipertiroidismo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tiroiditis: flujo escaso.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 28** Tema 7.6

Clase 7.6 en video

12 TEMA 7.6 · ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW Y SÍNDROMES TIROTÓXICOS

FOTO CLÍNICA

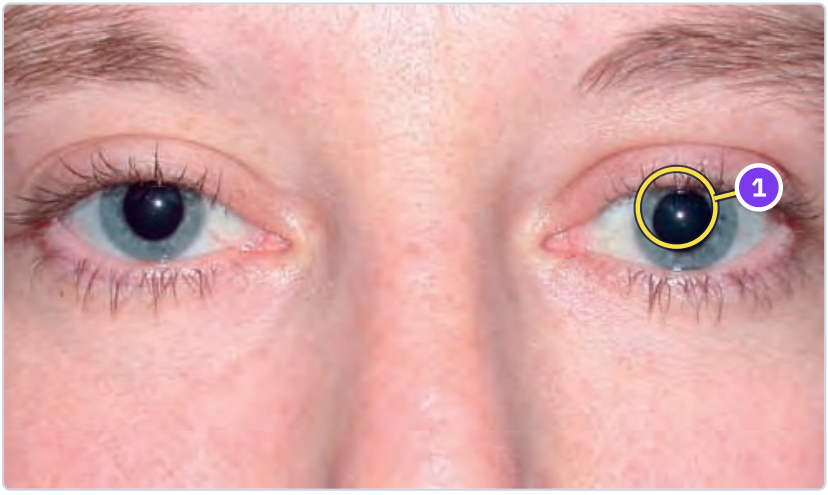


Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 67

QUÉ TIENES QUE VER

1. Retracción del párpado superior

DIAGNÓSTICO

Orbitopatía tiroidea: retracción palpebral

Se ve la esclera sobre el iris por retracción del párpado superior.

CONDUCTA INICIAL

Dejar de fumar; selenio en leve; corticoides EV en moderada-grave activa.

1.03.1.003 Hipertiroidismo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

6.02.3.006 Orbitopatía tiroidea — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Proptosis unilateral: descartar tumor orbitario.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2024 · P145** «Paciente con ojo rojo, temblor de manos, baja de peso y retracción palpebral. ¿Qué examen se solicita?» → **TSH y T4 libre**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 28** Tema 7.6

Clase 7.6 en video

13 TEMA 7.6 · ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW Y SÍNDROMES TIROTÓXICOS

IMAGEN RADIOLÓGICA

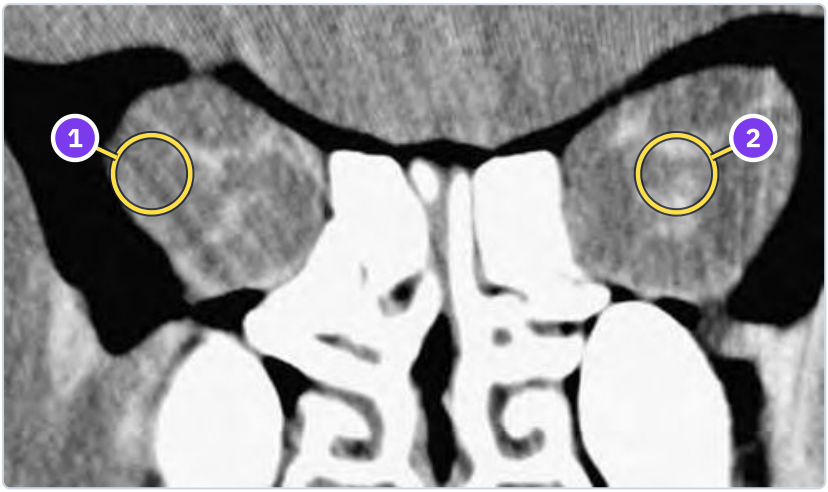


Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, p. 98

QUÉ TIENES QUE VER

1. Músculos rectos engrosados
2. Músculos rectos engrosados

DIAGNÓSTICO

Orbitopatía tiroidea en la TC coronal

Músculos extraoculares engrosados, respetando sus tendones.

CONDUCTA INICIAL

Neuropatía óptica compresiva: corticoides EV urgentes o descompresión.

6.02.3.006 **Orbitopatía tiroidea**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Miositis orbitaria: dolorosa y compromete el tendón.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 30** Tema 7.6

Clase 7.6 en video

14 TEMA 7.7 · MANEJO TERAPÉUTICO COMPARADO

IMAGEN RADIOLÓGICA

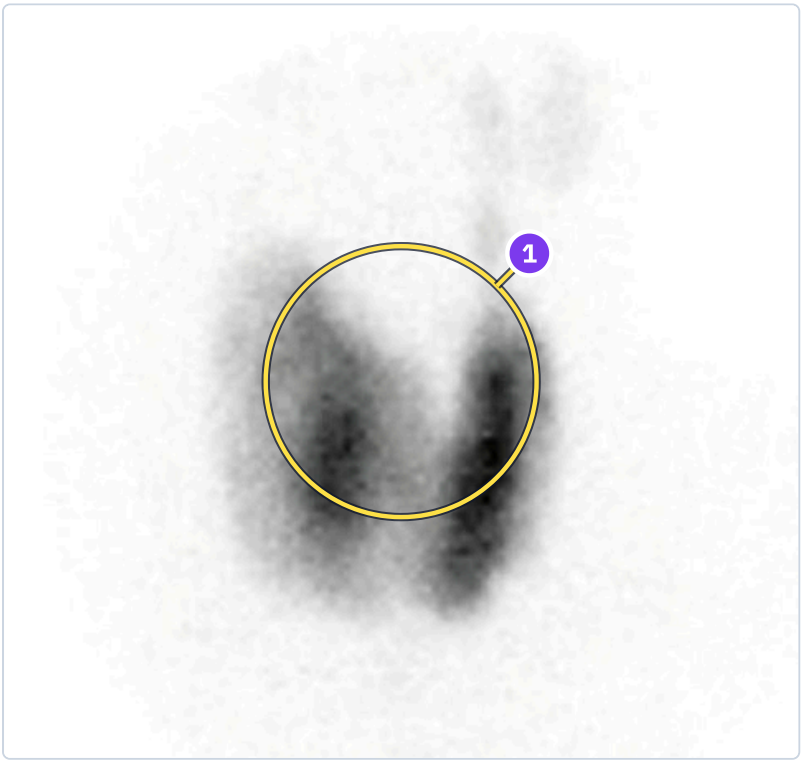


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1. Captación difusa de ambos lóbulos

DIAGNÓSTICO

Graves: captación difusa

Toda la glándula capta de forma difusa y aumentada.

CONDUCTA INICIAL

Primer episodio: tiamazol 12–18 meses esperando la remisión.

1.03.1.003 **Hipertiroidismo**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Adenoma tóxico: un solo nódulo capta.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 34** Tema 7.7

Clase 7.7 en video

15 TEMA 7.7 · MANEJO TERAPÉUTICO COMPARADO

IMAGEN RADIOLÓGICA

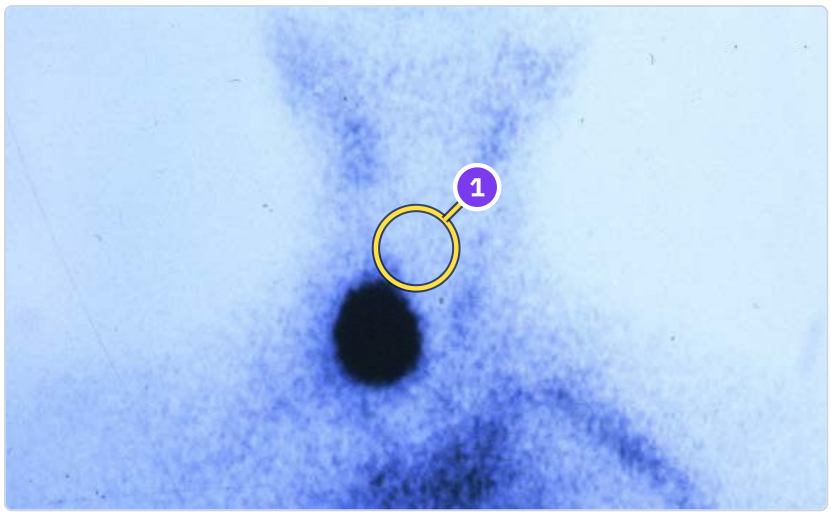


Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 57

QUÉ TIENES QUE VER

1. Nódulo caliente

DIAGNÓSTICO

Adenoma tóxico

Un nódulo caliente capta y suprime el resto de la glándula.

CONDUCTA INICIAL

No remite con fármacos: radioyodo o cirugía.

`1.03.1.003` **Hipertiroidismo**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

`4.01.1.034` **Patología benigna del tiroides**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Graves: captación difusa.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 34
Tema 7.7

Clase 7.7 en video

16 TEMA 7.7 · MANEJO TERAPÉUTICO COMPARADO

IMAGEN RADIOLÓGICA

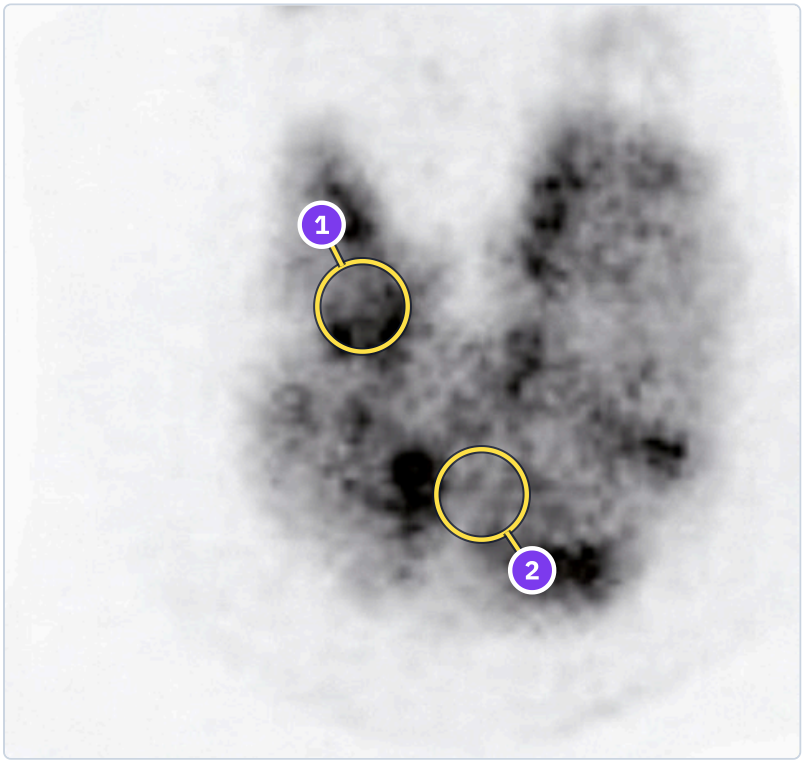


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1. Zonas hipercaptantes
2. Zonas hipocaptantes

DIAGNÓSTICO

Bocio multinodular tóxico

Zonas que captan alternan con zonas que no.

CONDUCTA INICIAL

Tratamiento definitivo obligatorio: radioyodo o tiroidectomía.

`1.03.1.003` **Hipertiroidismo**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

`4.01.1.034` **Patología benigna del tiroides**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Tiroiditis: glándula en blanco.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 34
Tema 7.7

Clase 7.7 en video

17 TEMA 7.7 · MANEJO TERAPÉUTICO COMPARADO

FOTO CLÍNICA

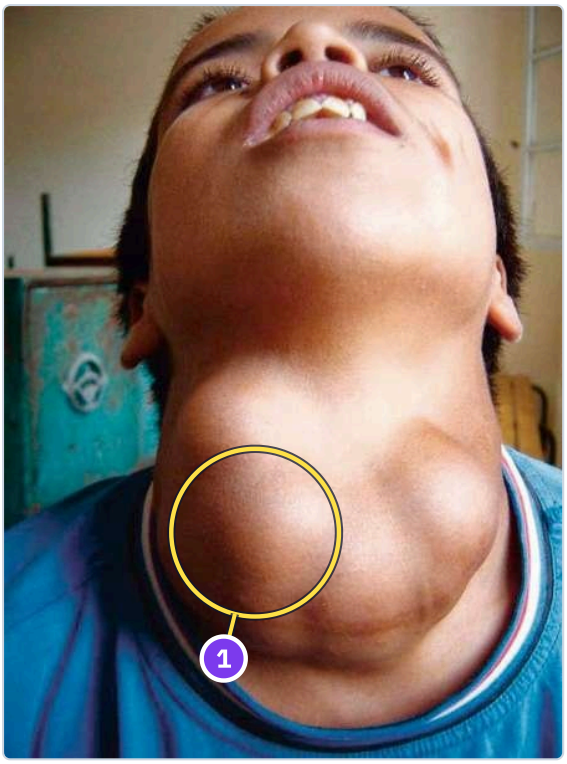


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 4381

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bocio gigante

DIAGNÓSTICO

Bocio gigante compresivo

Gran masa cervical que desvía la tráquea.

CONDUCTA INICIAL

Síntomas compresivos: tiroidectomía.

4.01.1.034 Patología benigna del tiroides
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

1.03.1.001 Bocio
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Linfoma tiroideo: crecimiento muy rápido.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P71 «Paciente de 25 años tras accidente de tránsito llega con timpanismo a la percusión del hemitórax derecho, ausencia de murmullo vesicular derecho,…» → **Neumotórax a tensión: descompresión con agu…**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 36
Tema 7.7

Clase 7.7 en video

18 TEMA 7.9 · NÓDULO TIROIDEO, CLASIFICACIÓN ACR TI-RADS Y CRITERIOS DE PAAF

IMAGEN RADIOLÓGICA

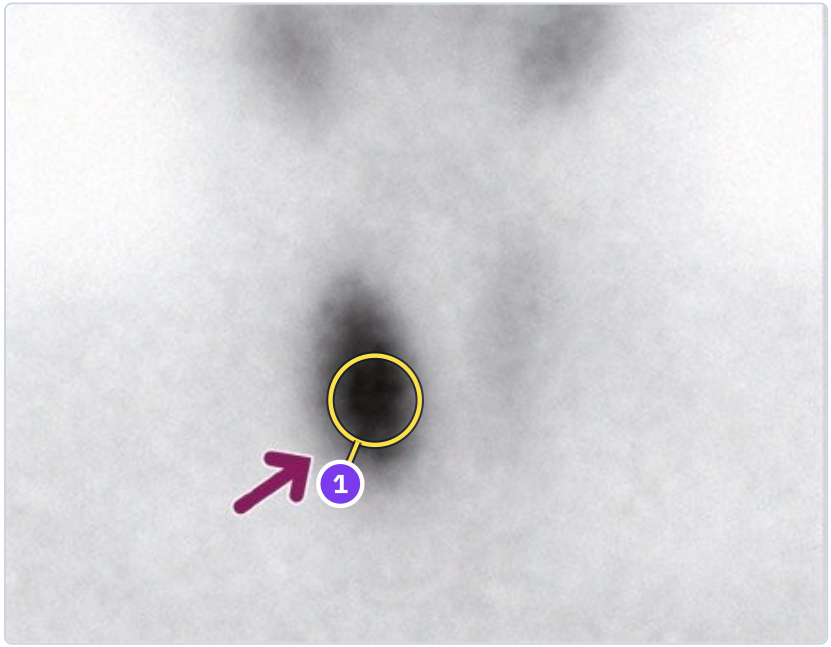


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo caliente

DIAGNÓSTICO

Gammagrafía: nódulo caliente

Capta todo el yodo y apaga el resto (flecha).

CONDUCTA INICIAL

TSH baja + nódulo caliente: riesgo de cáncer < 1%, no se punciona.

1.03.1.021 Nódulo tiroideo
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nódulo frío: hay que puncionar según TI-RADS.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P167 «Un paciente de 30 años, presenta un nódulo tiroideo, que en el examen físico se palpa de consistencia elástica, indoloro, sin adenopatías…» → **Realizar cintigrafía tiroidea**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 42
Tema 7.9

Clase 7.9 en video

19 TEMA 7.9 · NÓDULO TIROIDEO, CLASIFICACIÓN ACR TI-RADS Y CRITERIOS DE PAAF

ECOGRAFÍA

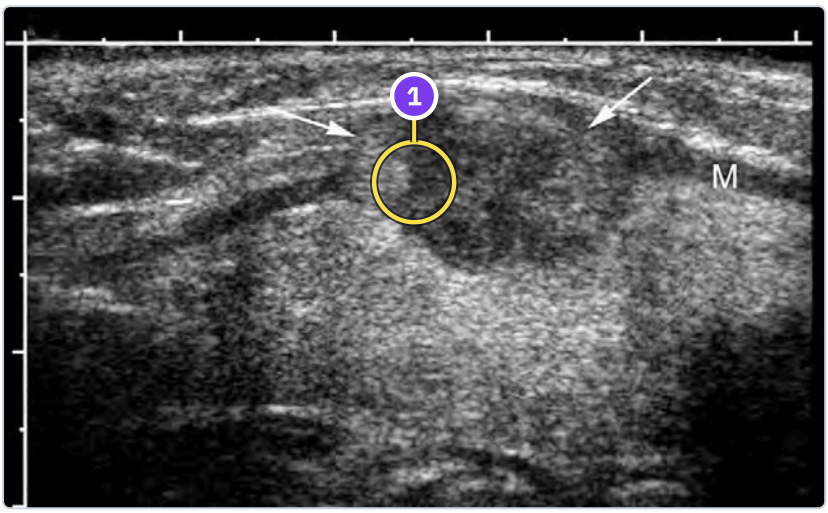


Imagen: Rumack, Diagnostic Ultrasound, p. 738

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo marcadamente hipoecogénico

DIAGNÓSTICO

Nódulo TI-RADS 5

Nódulo más oscuro que el músculo pretiroideo (M).

CONDUCTA INICIAL

TI-RADS 5 ≥ 1 cm: PAAF.

1.03.1.021 Nódulo tiroídeo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.03.4.001 Ecografía tiroídea — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Quiste: anecoico con refuerzo posterior.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO p. 42 Tema 7.9

Clase 7.9 en video

20 TEMA 7.9 · NÓDULO TIROIDEO, CLASIFICACIÓN ACR TI-RADS Y CRITERIOS DE PAAF

ECOGRAFÍA

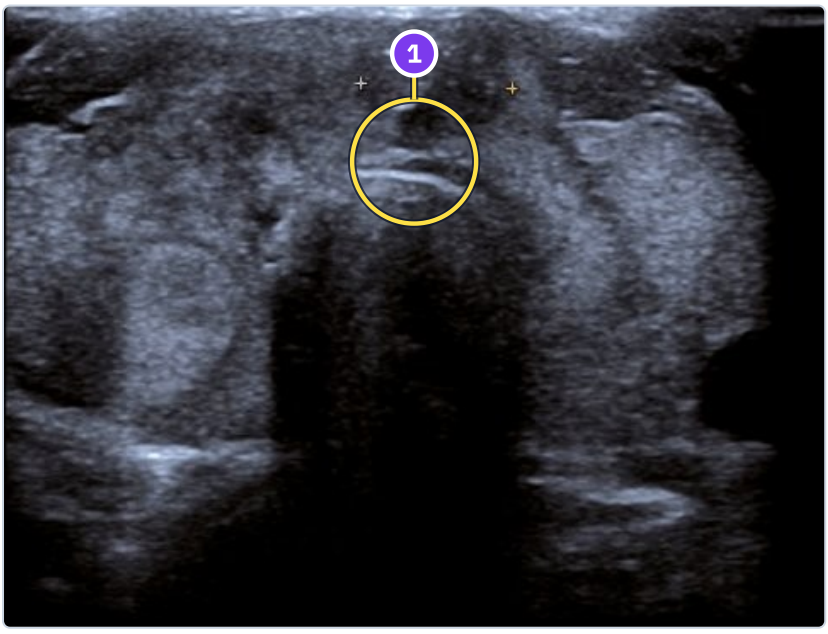


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 46

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo hipoecogénico

DIAGNÓSTICO

Nódulo con criterios de malignidad

Hipoecogénico, bordes irregulares, más alto que ancho y microcalcificaciones.

CONDUCTA INICIAL

Criterios de sospecha: PAAF y Bethesda.

1.03.1.021 Nódulo tiroídeo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.03.1.004 Cáncer del tiroides — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nódulo espongiforme: benigno, no se punciona.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO p. 42 Tema 7.9

Clase 7.9 en video

21 TEMA 7.9 · NÓDULO TIROIDEO, CLASIFICACIÓN ACR TI-RADS Y CRITERIOS DE PAAF

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love, p. 827

QUÉ TIENES QUE VER

1. Bocio visible

DIAGNÓSTICO

Bocio multinodular

Aumento de volumen cervical visible a simple vista.

CONDUCTA INICIAL

TSH y ecografía; PAAF de los nódulos sospechosos.

1.03.1.001	Bocio	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.03.1.021	Nódulo tiroídeo	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hashimoto: bocio difuso, firme y lobulado.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 43
Tema 7.9

Clase 7.9 en video

22 TEMA 7.10 · CÁNCER DE TIROIDES

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

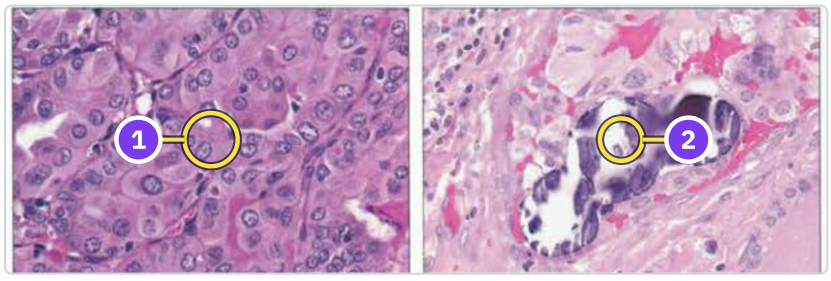


Imagen: Pathoma, Fig. 15.5

QUÉ TIENES QUE VER

1. Papilas
2. Cuerpo de psamoma

DIAGNÓSTICO

Carcinoma papilar

Papilas, cuerpos de psamoma y núcleos en vidrio esmerilado.

CONDUCTA INICIAL

Tiroidectomía; radioyodo según riesgo; seguimiento con tiroglobulina.

1.03.1.004	Cáncer del tiroides	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
4.01.1.033	Cáncer del tiroides	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Folicular: el diagnóstico exige invasión capsular o vascular.

PREGUNTA REAL

Julio 2018 · P74 «Un hombre de 31 años consulta por aumento de volumen en el cuello, que se palpa como un nódulo tiroideo de consistencia firme. Es estudiado con…» → **Biopsia citológica**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 46
Tema 7.10

Clase 7.10 en video

23 TEMA 7.11 · SÍNDROME DE CUSHING

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons «CushingsFace.jpg», CC BY 2.5, Ozlem Celik, Mutlu Niyazoglu, Hikmet Soylu and Pinar Kadiogl

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cara redonda y pletórica

DIAGNÓSTICO

Facies de luna llena

Cara redonda y roja; causa más frecuente: corticoides exógenos.

CONDUCTA INICIAL

Descartar corticoides (incluso inhalados) antes de pedir exámenes.

1.03.1.006 **Síndrome de Cushing** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Obesidad simple: sin miopatía ni estrías violáceas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 53** Tema 7.11

Clase 7.11 en video

24 TEMA 7.11 · SÍNDROME DE CUSHING

ESQUEMA

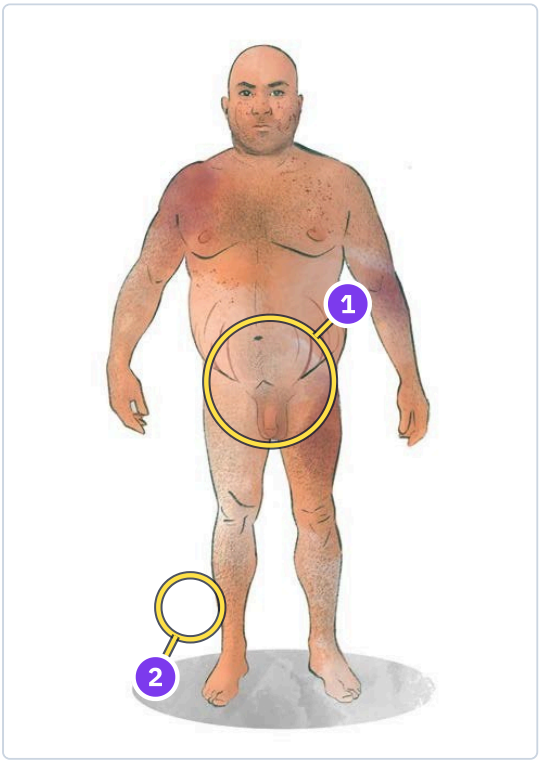


Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 76

QUÉ TIENES QUE VER

1. Obesidad central
2. Extremidades delgadas

DIAGNÓSTICO

Fenotipo cushingoide

Obesidad central con extremidades delgadas.

CONDUCTA INICIAL

Tamizaje: cortisol libre urinario 24 h, cortisol salival nocturno o supresión con 1 mg de dexametasona.

1.03.1.006 **Síndrome de Cushing** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.03.4.007 **Cortisol libre 24 horas** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Síndrome metabólico: sin atrofia muscular.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P18** «Una paciente de 28 años aumento de peso de 5 meses de evolución, asociado a malestar general. Refiere importante astenia, que ha progresado y…» → **Cortisol libre urinario de 24 horas**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 53** Tema 7.11

Clase 7.11 en video

25 TEMA 7.11 · SÍNDROME DE CUSHING

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 77

QUÉ TIENES QUE VER

1 Equimosis extensa

DIAGNÓSTICO

Equimosis por fragilidad capilar

Grandes moretones con traumas mínimos.

CONDUCTA INICIAL

Signo de hipercortisolismo: sospechar Cushing.

1.03.1.006 Síndrome de Cushing

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coagulopatía: pedir plaquetas y TP.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 53** Tema 7.11

Clase 7.11 en video

26 TEMA 7.11 · SÍNDROME DE CUSHING

IMAGEN RADIOLÓGICA

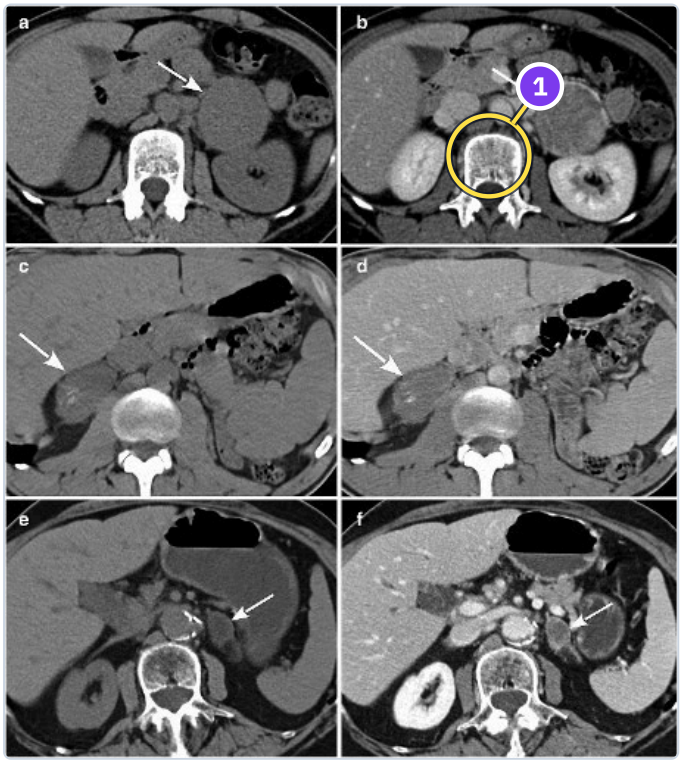


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa suprarrenal

DIAGNÓSTICO

TAC suprarrenal en el Cushing

Masas suprarrenales (flechas) en distintos casos.

CONDUCTA INICIAL

ACTH suprimida: origen suprarrenal; TAC de suprarrenales.

1.03.1.006 Síndrome de Cushing

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

ACTH alta: buscar adenoma hipofisario.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 52** Tema 7.11

Clase 7.11 en video

27 TEMA 7.12 · INSUFICIENCIA SUPRARRENAL CRÓNICA

FOTO CLÍNICA

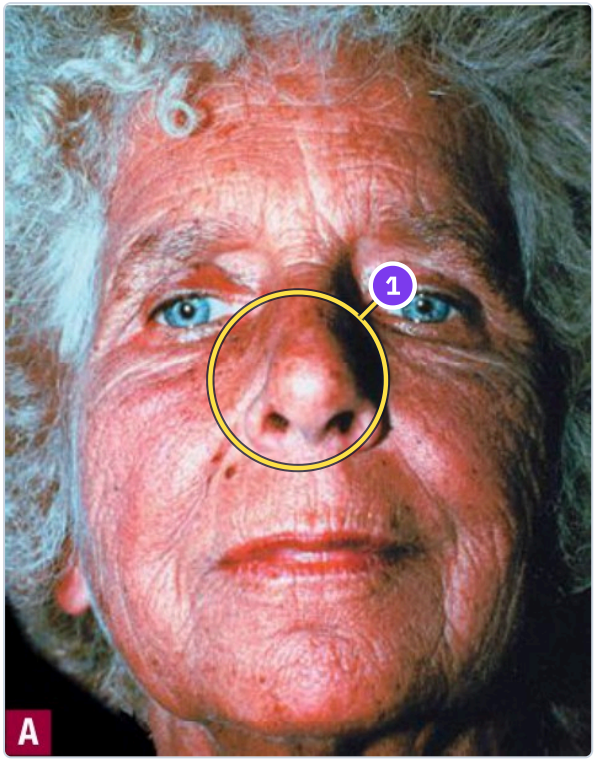


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., Fig. 152-16A

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hiperpigmentación facial

DIAGNÓSTICO

Enfermedad de Addison: hiperpigmentación

Piel bronceada, por exceso de ACTH.

CONDUCTA INICIAL

Cortisol AM bajo con ACTH alta; hidrocortisona y fludrocortisona.

1.03.1.007	Insuficiencia suprarrenal crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.03.4.006	Cortisol plasmático	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Insuficiencia secundaria: ACTH baja, sin hiperpigmentación.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P112 «Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja…» → **Enfermedad de Addison**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 57
Tema 7.12

Clase 7.12 en video

28 TEMA 7.12 · INSUFICIENCIA SUPRARRENAL CRÓNICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., Fig. 152-16B

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pliegues palmares oscuros

DIAGNÓSTICO

Addison: pliegues palmares

Pigmento en los pliegues de las palmas.

CONDUCTA INICIAL

Educación: doblar la dosis de hidrocortisona en enfermedad intercurrente.

1.03.1.007	Insuficiencia suprarrenal crónica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pigmentación racial: sin hipotensión ni hiponatremia.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P102 «Un paciente alcohólico, en situación de calle, con antecedente de una tuberculosis tratada hace 2 años, consulta por astenia de 3 meses de…» → **Enfermedad de Addison**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 58
Tema 7.12

Clase 7.12 en video

29 TEMA 7.13 · CRISIS SUPRARRENAL AGUDA Y SHOCK REFRACTARIO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 19-7 (de Fitzpatrick, Color Atlas 8.ª ed.)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Púrpura necrótica

DIAGNÓSTICO

Púrpura fulminante (Waterhouse-Friderichsen)

Equimosis necróticas extensas en sepsis meningocócica.

CONDUCTA INICIAL

Hemorragia suprarrenal: hidrocortisona 100 mg EV inmediata, sin esperar exámenes.

1.03.2.003 Insuficiencia suprarrenal aguda

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Vasculitis: lesiones palpables sin shock.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P20 «Un paciente tiene diarrea de 3 días de evolución, asociada a malestar general marcado y vómitos alimentarios, con deterioro del estado general….» → **Insuficiencia suprarrenal aguda**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 60
Tema 7.13

Clase 7.13 en video

30 TEMA 7.13 · CRISIS SUPRARRENAL AGUDA Y SHOCK REFRACTARIO

FOTO CLÍNICA

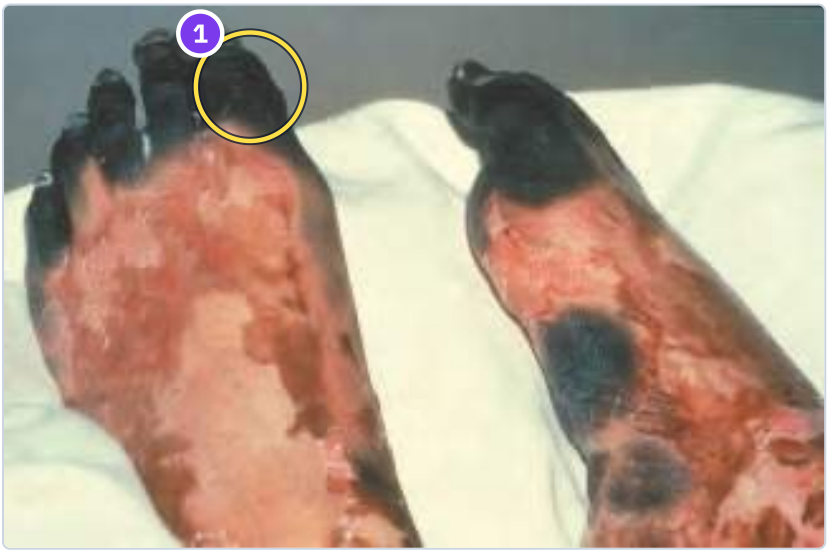


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 619

QUÉ TIENES QUE VER

1 Necrosis de los ortejos

DIAGNÓSTICO

Necrosis distal en la sepsis

Necrosis de los ortejos por coagulación intravascular.

CONDUCTA INICIAL

Crisis suprarrenal: hidrocortisona EV, volumen y antibióticos.

1.03.2.003 Insuficiencia suprarrenal aguda

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Gangrena por enfermedad arterial: progresiva, no aguda.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 60
Tema 7.13

Clase 7.13 en video

31 TEMA 7.14 · HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO (SÍNDROME DE CONN) E HTA SECUNDARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

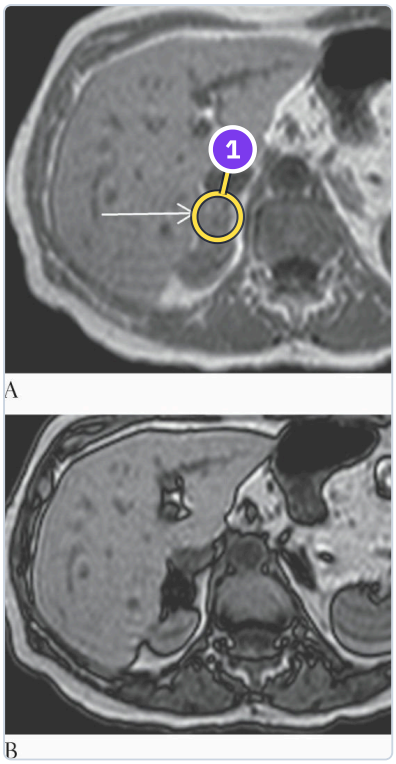


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 383

QUÉ TIENES QUE VER

1 Adenoma suprarrenal

DIAGNÓSTICO

Adenoma suprarrenal en la RM

Pequeño nódulo suprarrenal (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Hiperaldosteronismo: relación aldosterona/renina; cateterismo de venas suprarrenales antes de operar.

1.03.1.009 Hipertensión arterial de origen endocrino — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hiperplasia bilateral: espironolactona, no cirugía.

PREGUNTA REAL

Julio 2016 · P59 «Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y…» → **Hiperaldosteronismo**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 65
Tema 7.14

Clase 7.14 en video

32 TEMA 7.15 · FEOCROMOCITOMA Y PARAGANGLIOMAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

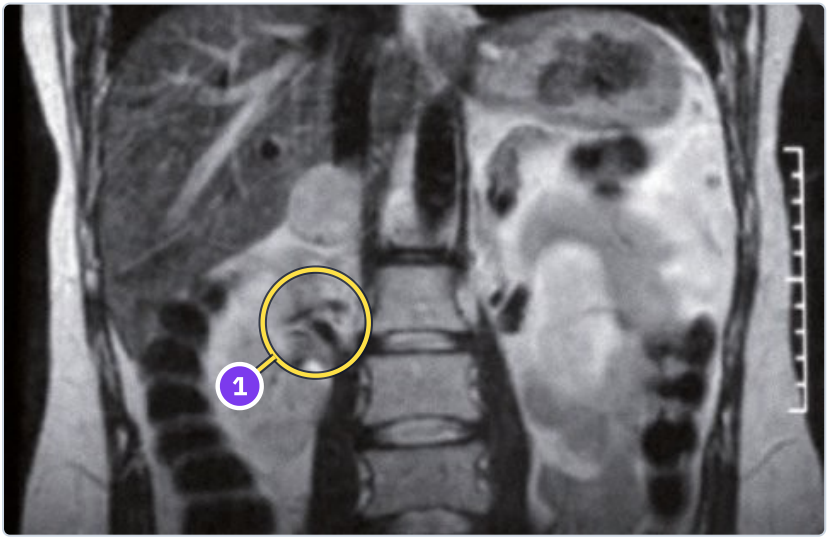


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 59

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa suprarrenal

DIAGNÓSTICO

Feocromocitoma en la RM

Masa suprarrenal brillante en T2.

CONDUCTA INICIAL

Metanefrinas; bloqueo alfa antes que beta y antes de la cirugía.

1.03.1.009 Hipertensión arterial de origen endocrino — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.03.1.023 Tumor suprarrenal — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Adenoma: pobre en señal T2.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 68
Tema 7.15

Clase 7.15 en video

33 TEMA 7.15 · FEOCROMOCITOMA Y PARAGANGLIOMAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

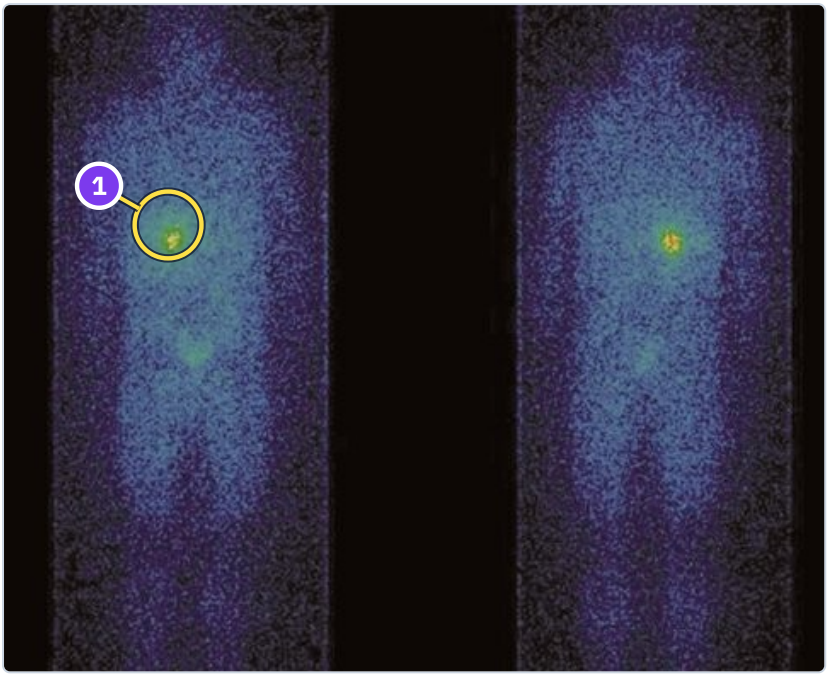


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 58

QUÉ TIENES QUE VER

1 Foco captante

DIAGNÓSTICO

Gammagrafía con MIBG

Foco de captación en la suprarrenal.

CONDUCTA INICIAL

Localiza feocromocitomas y paragangliomas extraadrenales.

4.03.1.023 Tumor suprarrenal

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Adenoma no funcionante: no capta MIBG.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO

p. 68

Tema 7.15

Clase 7.15 en video

34 TEMA 7.15 · FEOCROMOCITOMA Y PARAGANGLIOMAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

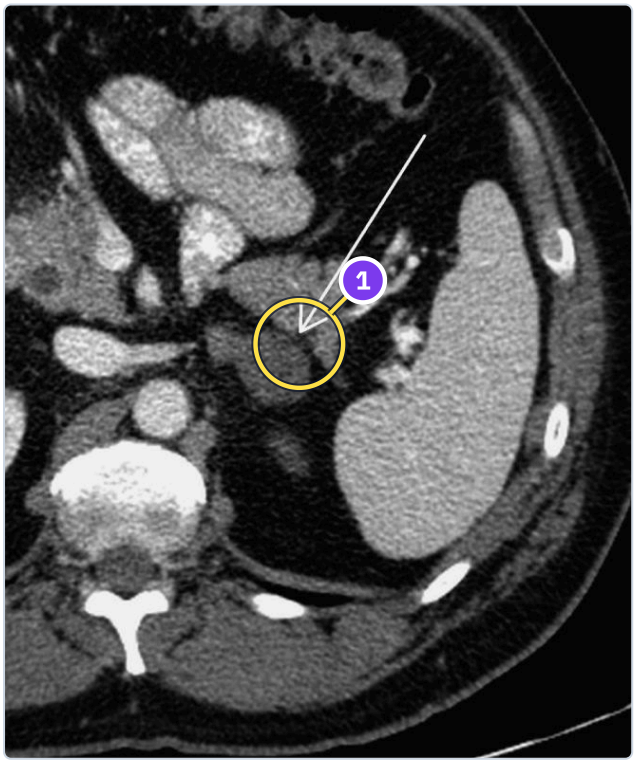


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 382

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo suprarrenal

DIAGNÓSTICO

Incidentaloma suprarrenal en la TAC

Nódulo suprarrenal (flecha) hallado por casualidad.

CONDUCTA INICIAL

Estudiar función (cortisol, metanefrinas, aldosterona); > 4 cm o > 10 UH: cirugía.

1.03.1.022 Incidentaloma suprarrenal

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Metástasis: en paciente oncológico, crece.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO

p. 68

Tema 7.15

Clase 7.15 en video

35 TEMA 7.16 · HIPERCALCEMIA E HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO VERSUS NEOPLÁSICO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Fundamentals of Skeletal Radiology (Helms), p. 15

QUÉ TIENES QUE VER

1. Resorción subperióstica
2. Resorción subperióstica

DIAGNÓSTICO

Osteítis fibrosa quística

Resorción subperióstica de las falanges (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Hiperparatiroidismo: PTH y calcio altos; paratiroidectomía si cumple criterios.

1.03.1.020	Hipercalcemias e hipocalcemias	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.03.4.010	PTH, calcemia	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Osteoporosis: hueso fino sin resorción subperióstica.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P175 «Un paciente de 32 años, con antecedente de litiasis renal a repetición se realiza exámenes, que muestran calcio plasmático: 9,8 mg/dl, albúmina:…» → **Hiperparatiroidismo primario**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 75
Tema 7.16

Clase 7.16 en video

36 TEMA 7.16 · HIPERCALCEMIA E HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO VERSUS NEOPLÁSICO

ESQUEMA

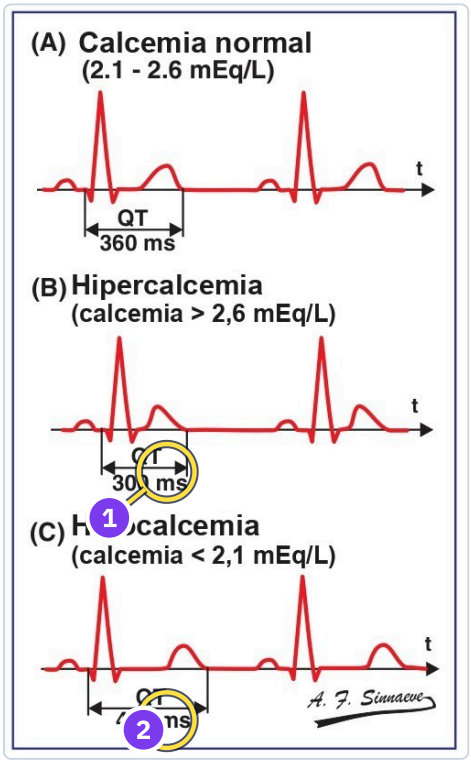


Imagen: ECG from Basics to Essentials, p. 331

QUÉ TIENES QUE VER

1. QT corto
2. QT largo

DIAGNÓSTICO

El QT y el calcio

Hipercalcemia acorta el QT; hipocalcemia lo alarga.

CONDUCTA INICIAL

Hipercalcemia grave: suero fisiológico EV y luego bifosfonato.

1.03.2.004	Hipercalcemia aguda	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.03.1.020	Hipercalcemias e hipocalcemias	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipokalemia: también prolonga, con onda U.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P79 «Hombre de 55 años con hipercalcemia severa (Ca 13.5 mg/dL), náuseas, poliuria, confusión y deshidratación. PTH elevada. ¿Cuál es el tratamiento…» → **Hidratación EV con solución salina 0.9%**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 75
Tema 7.16

Clase 7.16 en video

37 TEMA 7.16 · HIPERCALCEMIA E HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO VERSUS NEOPLÁSICO

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

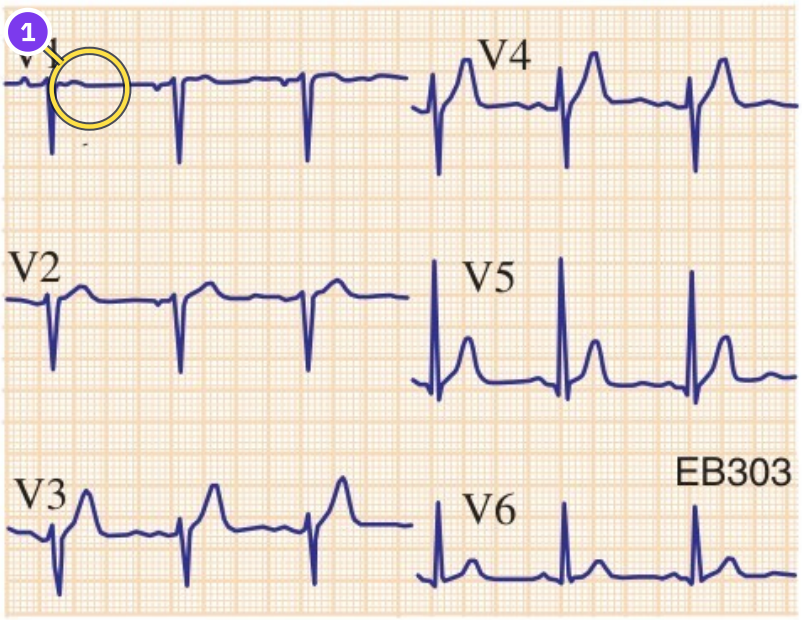


Imagen: ECG from Basics to Essentials, p. 331

QUÉ TIENES QUE VER

1 QT corto

DIAGNÓSTICO

ECG de hipercalcemia

QT corto, con la T casi pegada al QRS.

CONDUCTA INICIAL

Hidratación EV con solución salina 0,9%.

1.03.2.004 **Hipercalcemia aguda**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.08.2.004 **Hipercalcemia**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Digitálicos: ST en cubeta.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P105** «Paciente con cáncer de próstata y calcio de 14 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?» → **Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 75
Tema 7.16

Clase 7.16 en video

38 TEMA 7.16 · HIPERCALCEMIA E HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO VERSUS NEOPLÁSICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

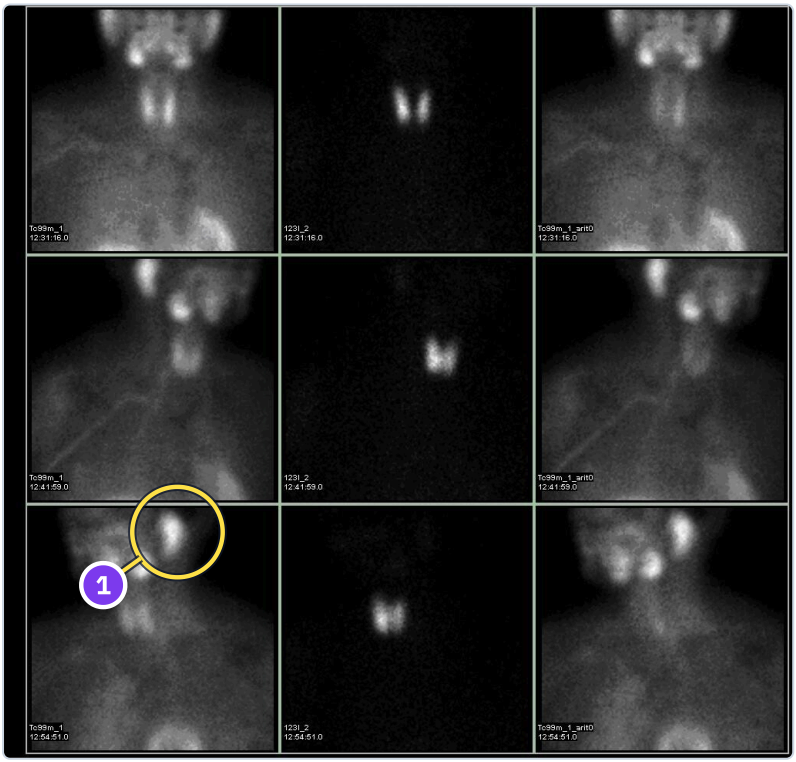


Imagen: Wikimedia Commons «Parathyroid subtraction.jpg», CC BY 3.0, Myohan at en.wikipedia

QUÉ TIENES QUE VER

1 Adenoma paratiroideo

DIAGNÓSTICO

Gammagrafía con sestamibi

Adenoma de paratiroides que retiene el trazador (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Localiza el adenoma antes de la paratiroidectomía.

1.03.4.010 **PTH, calcemia**
examen/procedimiento

1.03.1.020 **Hipercalcemias e hipocalcemias**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nódulo tiroideo: el sestamibi se lava antes.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P32** «En el estudio de una osteoporosis de una paciente, se pesquisa tiene calcemia de 11 mg/dl, niveles de paratohormona de 155 UI/L (VN: 15 a 55),…» → **Hiperparatiroidismo**…

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 76
Tema 7.16

Clase 7.16 en video

39 TEMA 7.17 · HIPOCALCEMIA AGUDA Y CRÓNICA

FOTO CLÍNICA

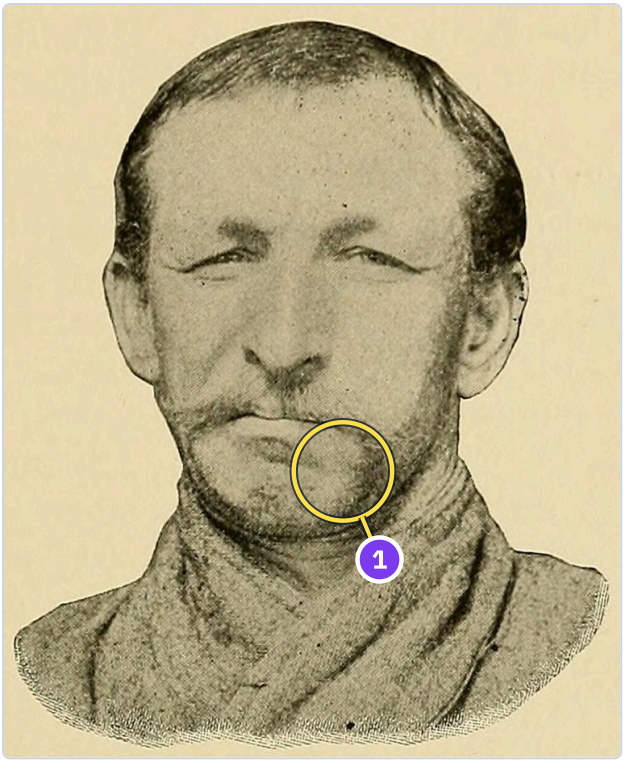


Imagen: Wikimedia Commons «Facial spasm (Chvostek's symptom).jpg», Public domain, Alfred Loomis & William Thompson

QUÉ TIENES QUE VER

1 Contracción de la comisura

DIAGNÓSTICO

Signo de Chvostek

Contracción de la comisura al percutir el nervio facial.

CONDUCTA INICIAL

Hipocalcemia sintomática: gluconato de calcio EV.

1.03.2.005 **Tetania**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Presente en 10% de las personas sanas.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P110** «Paciente con tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, presenta debilidad, parestesias y signo de Chvostek positivo. ¿Cuál es el tratamiento inicial?» → **Gluconato de calcio**…

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 79** Tema 7.17

Clase 7.17 en video

40 TEMA 7.17 · HIPOCALCEMIA AGUDA Y CRÓNICA

FOTO CLÍNICA

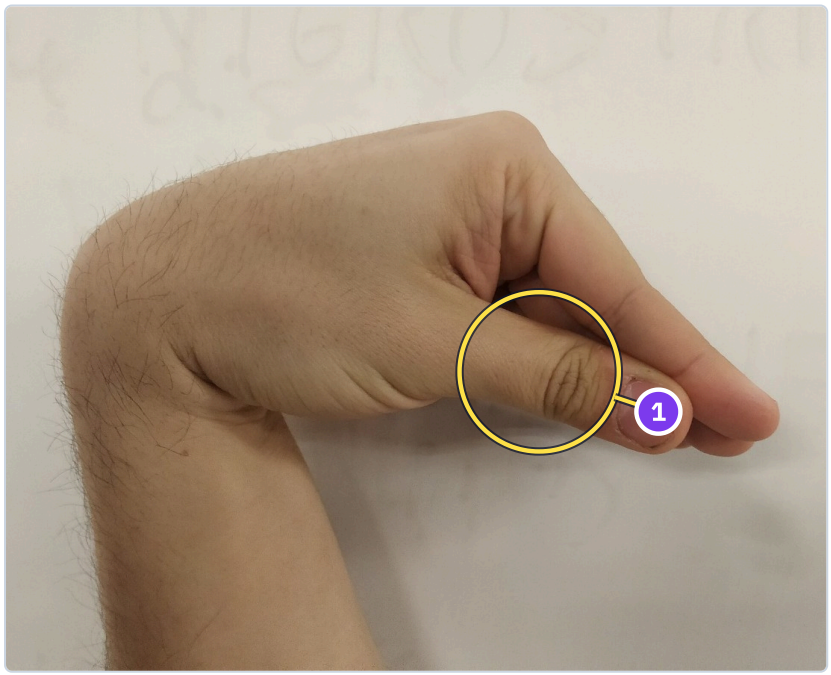


Imagen: Wikimedia Commons «Trousseau's Sign of Latent Tetany.jpg», CC BY-SA 4.0, ver autor en Commons

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mano en comadrón

DIAGNÓSTICO

Signo de Trousseau

Mano en comadrón al inflar el manguito sobre la sistólica.

CONDUCTA INICIAL

Postiroidectomía: gluconato de calcio EV.

1.03.2.005 **Tetania**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Más específico que Chvostek.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P25** «Un paciente, con antecedente de tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, en tratamiento con levotiroxina, calcio y vitamina D, por vía oral,…» → **Gluconato de calcio endovenoso**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 79** Tema 7.17

Clase 7.17 en video

41 TEMA 7.18 · OSTEOPOROSIS

ESQUEMA

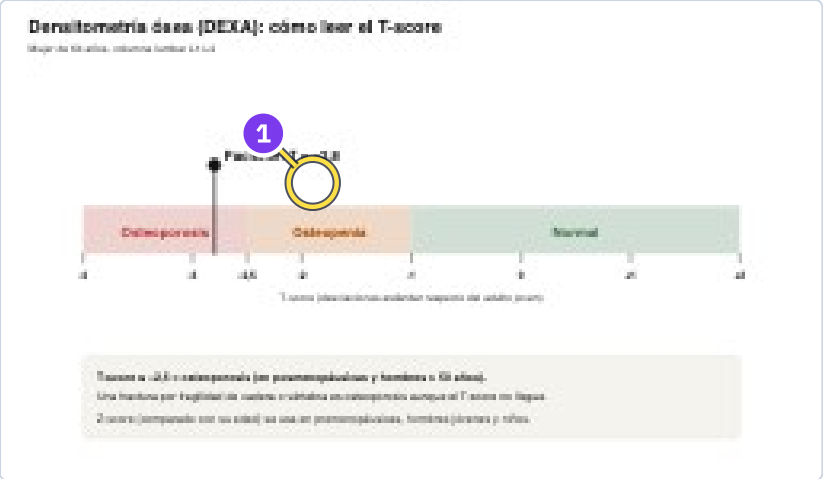


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 T-score del paciente

DIAGNÓSTICO

Densitometría: cómo leer el T-score

T ≤ −2,5 = osteoporosis; entre −1 y −2,5 = osteopenia.

CONDUCTA INICIAL

Osteoporosis: calcio, vitamina D y bifosfonato.

1.03.4.002 **Densitometría ósea** — examen/procedimiento

1.03.1.018 **Osteoporosis** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Z-score: en premenopáusicas y niños.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P114 «Una paciente de 65 años, en tratamiento con calcio 2 gramos al día y vitamina D, 600 UI al día, se realiza una densitometría ósea que muestra un…» → **Agregar bifosfonatos al tratamiento**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 83
Tema 7.18

Clase 7.18 en video

42 TEMA 7.18 · OSTEOPOROSIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

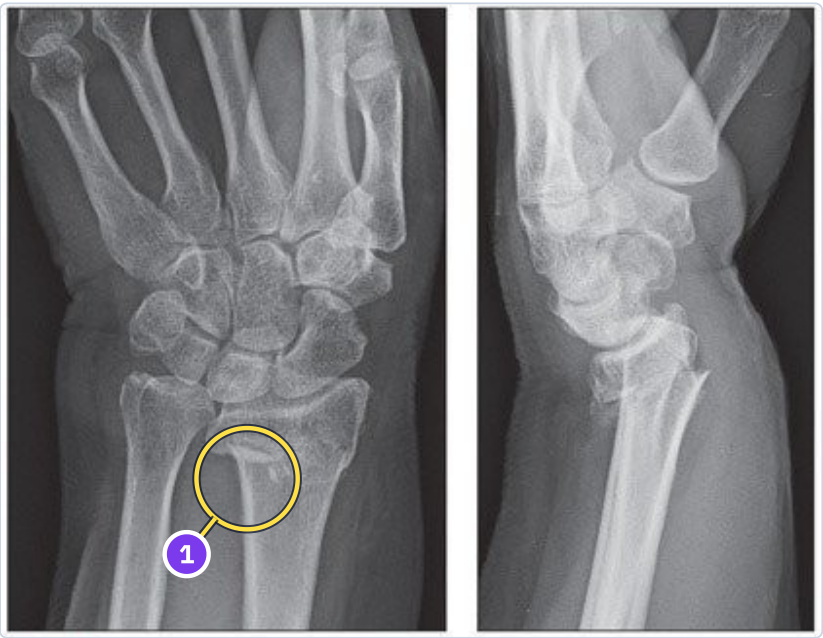


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 569

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura distal del radio

DIAGNÓSTICO

Fractura de Colles

Fractura distal del radio con desplazamiento dorsal.

CONDUCTA INICIAL

Fractura por fragilidad: es osteoporosis aunque la DEXA no llegue a −2,5.

1.03.1.018 **Osteoporosis** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Smith: desplazamiento palmar.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 83
Tema 7.18

Clase 7.18 en video

43 TEMA 7.18 · OSTEOPOROSIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

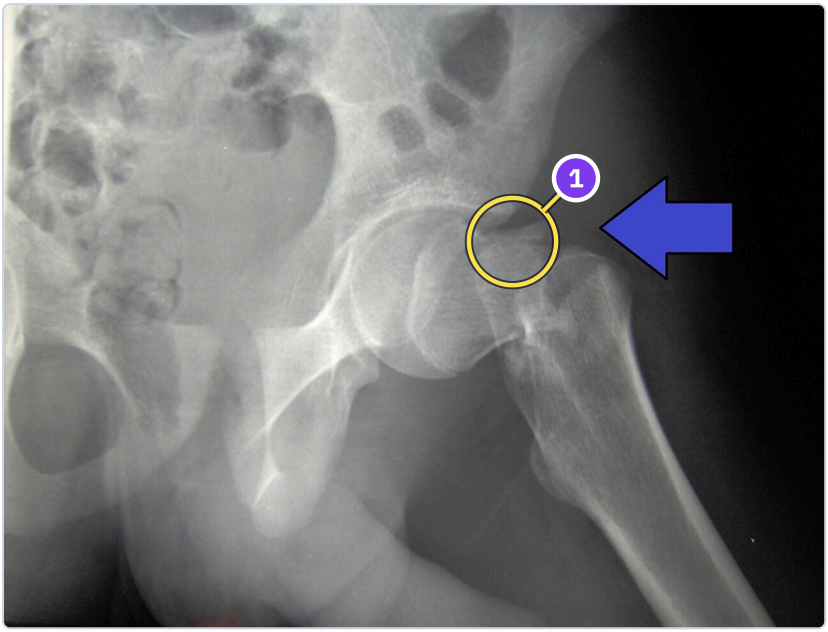


Imagen: Wikimedia Commons «Cdm hip fracture 343.jpg», CC BY-SA 3.0, Booyabazooka

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura del cuello femoral

DIAGNÓSTICO

Fractura del cuello del fémur

Fractura de cadera (flecha) por fragilidad.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía precoz; luego tratar la osteoporosis.

1.03.1.018 Osteoporosis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.07.1.015 Osteoporosis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Contusión: Rx sin rasgo.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 83** Tema 7.18

Clase 7.18 en video

44 TEMA 7.18 · OSTEOPOROSIS

FOTO CLÍNICA

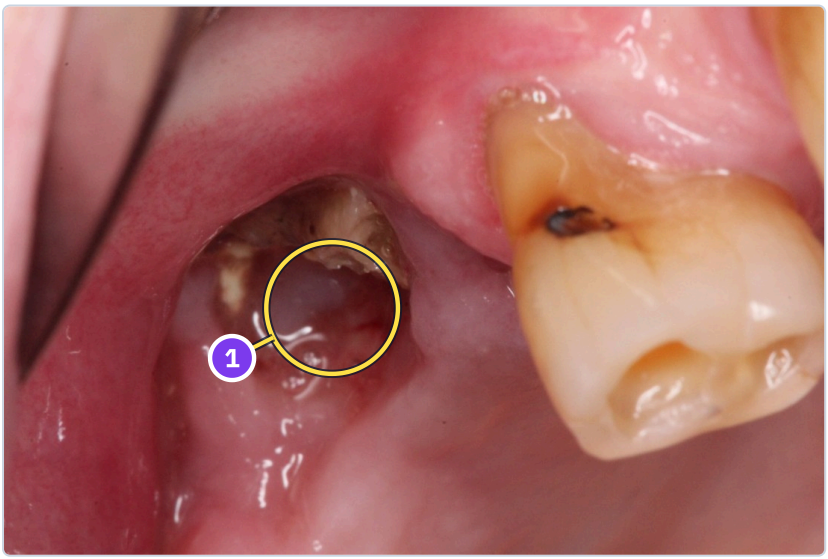


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hueso expuesto

DIAGNÓSTICO

Osteonecrosis mandibular por bifosfonatos

Hueso expuesto que no cicatriza tras una extracción.

CONDUCTA INICIAL

Evaluación dental antes de iniciar bifosfonatos.

1.03.1.018 Osteoporosis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Alveolitis: dolor sin hueso necrótico.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 83** Tema 7.18

Clase 7.18 en video

45 TEMA 7.18 · OSTEOPOROSIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

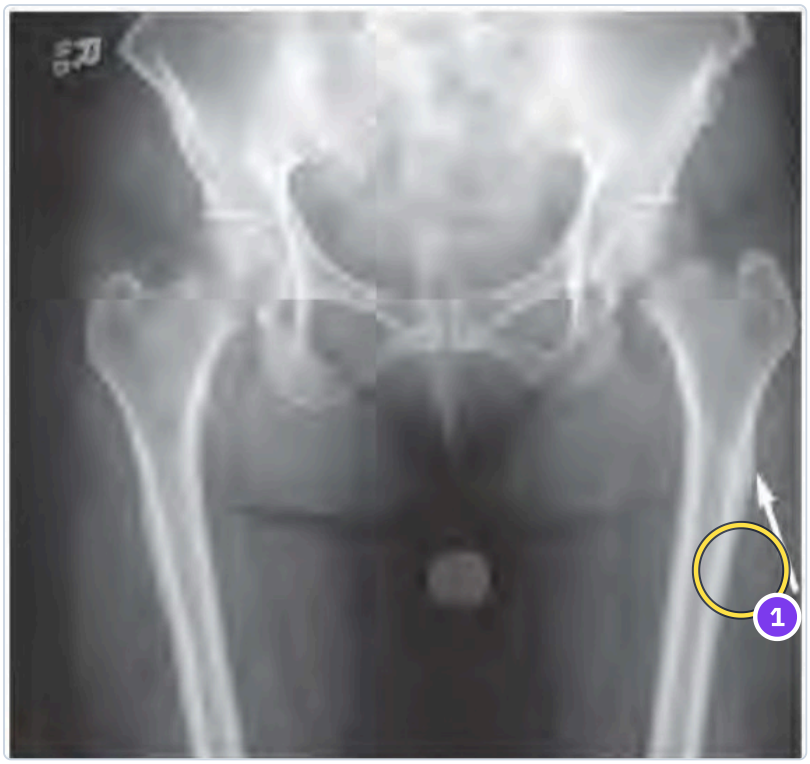


Imagen: Fundamentals of Skeletal Radiology (Helms), p. 165

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura atípica

DIAGNÓSTICO

Fractura atípica subtrocantérea

Rasgo transverso en la cortical lateral del fémur (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Asociada al uso prolongado de bifosfonatos: suspenderlos.

1.03.1.018 **Osteoporosis**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Fractura de cuello: más proximal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 83
Tema 7.18

Clase 7.18 en video

46 TEMA 7.19 · DÉFICIT DE VITAMINA D, OSTEOMALACIA DEL ADULTO Y RAQUITISMO

FOTO CLÍNICA

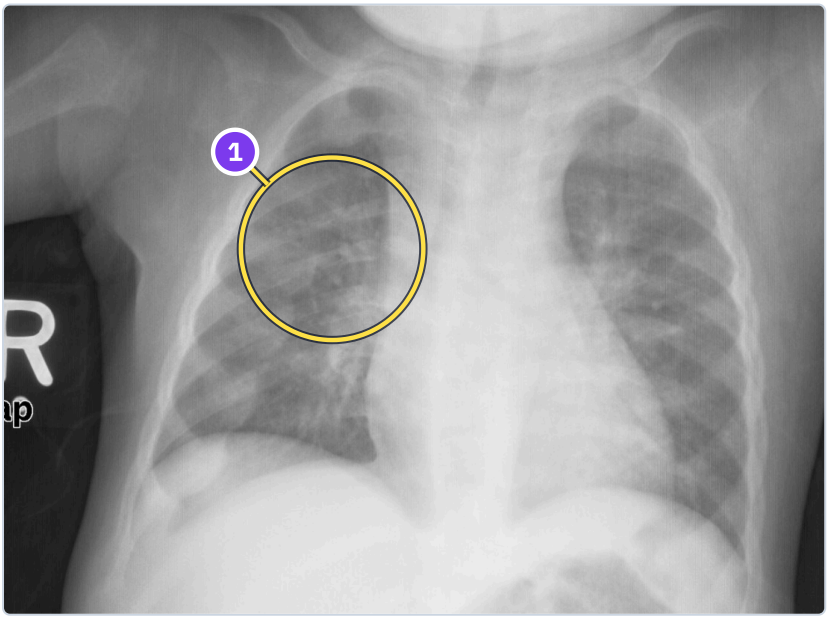


Imagen: Wikimedia Commons «RicketsChestXray.jpg», CC BY-SA 3.0, Frank Gaillard

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rosario costal

DIAGNÓSTICO

Rosario raquítico

Prominencia de las uniones condrocostales.

CONDUCTA INICIAL

Raquitismo carencial: vitamina D y calcio.

1.02.1.017 **Síndromes carenciales de vitaminas y minerales**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Escorbuto: también rosario, con hemorragias.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 87
Tema 7.19

Clase 7.19 en video

47 TEMA 7.19 · DÉFICIT DE VITAMINA D, OSTEOMALACIA DEL ADULTO Y RAQUITISMO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 646

QUÉ TIENES QUE VER

1 Muñeca ensanchada

DIAGNÓSTICO

Muñecas ensanchadas en el raquitismo

Metáfisis distales anchas.

CONDUCTA INICIAL

Fosfatasa alcalina alta, calcio y fósforo bajos.

1.02.1.017 **Síndromes carenciales de vitaminas y minerales**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

2.01.4.018 **Perfil bioquímico**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hipofosfatemia ligada al X: no responde a vitamina D.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 87** Tema 7.19

Clase 7.19 en video

48 TEMA 7.19 · DÉFICIT DE VITAMINA D, OSTEOMALACIA DEL ADULTO Y RAQUITISMO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 3.0, ver autor en Commons

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pseudofractura

DIAGNÓSTICO

Línea de Looser-Milkman

Pseudofractura: banda radiolúcida perpendicular a la cortical (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Osteomalacia: vitamina D; en bypass gástrico, pesquisar el déficit.

1.02.1.017 **Síndromes carenciales de vitaminas y minerales**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura por estrés: con callo.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P25** «Una paciente de 34 años, con antecedente de by pass gástrico hace 2 años, por obesidad mórbida, consulta por astenia, disnea y marcada…» → **Déficit de cianocobalamina**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 87** Tema 7.19

Clase 7.19 en video

49 TEMA 7.20 · MASAS SELARES, ADENOMAS HIPOFISIARIOS Y APOPLEJÍA HIPOFISARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

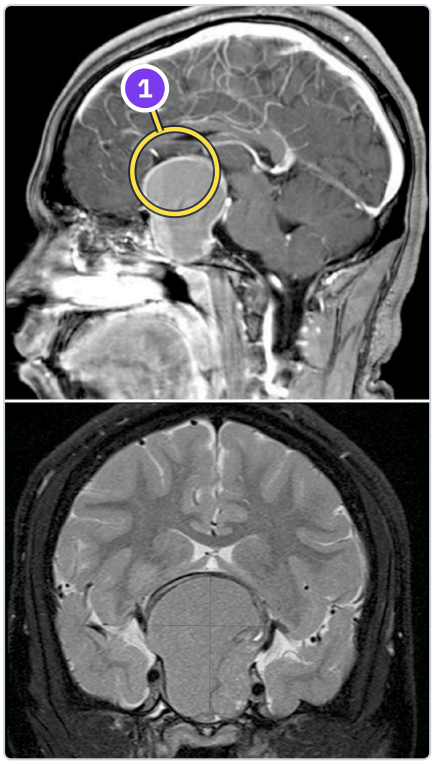


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 24

QUÉ TIENES QUE VER

1 Macroadenoma

DIAGNÓSTICO

Macroadenoma hipofisario en la RM

Masa selar que sube hacia el quiasma.

CONDUCTA INICIAL

Campo visual y perfil hormonal; cirugía transesfenoidal salvo prolactinoma.

1.03.1.013 Tumores hipofisarios — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.10.1.028 Tumores de región sellar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Craneofaringioma: quístico y calcificado.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P138 «Una paciente cefalea de 4 semanas de evolución, mayor en las mañanas, que se asocia a vómitos y, además, refiere alteraciones visuales. Al examen…» → **Macroadenoma**…

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 94
Tema 7.20

Clase 7.20 en video

50 TEMA 7.20 · MASAS SELARES, ADENOMAS HIPOFISIARIOS Y APOPLEJÍA HIPOFISARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

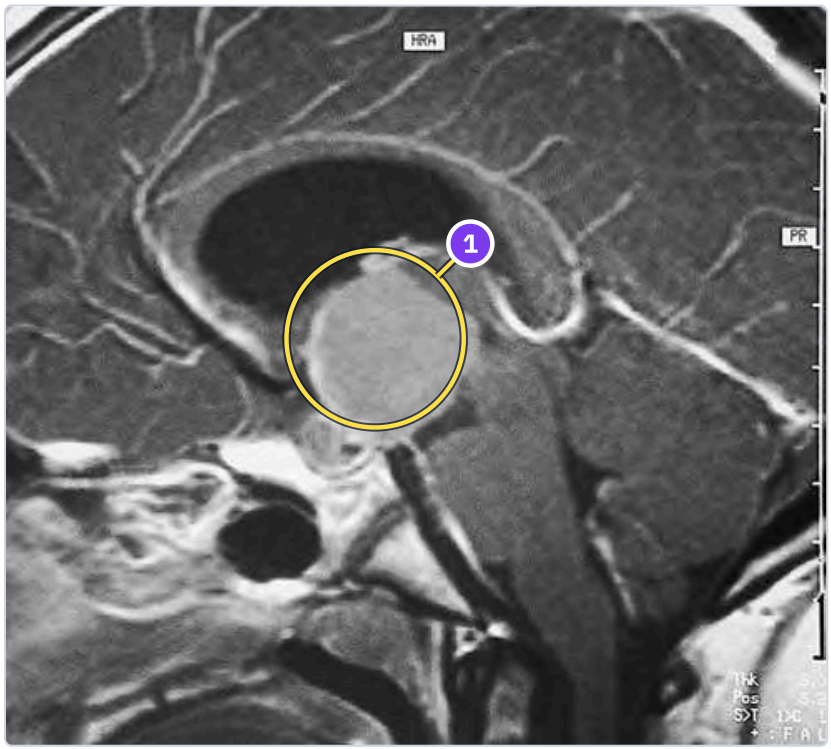


Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 830

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa supraselar

DIAGNÓSTICO

Craneofaringioma supraselar

Masa supraselar quística en la RM.

CONDUCTA INICIAL

Niño con talla baja y hemianopsia: RM.

1.10.1.028 Tumores de región sellar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Adenoma: nace de la silla.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 94
Tema 7.20

Clase 7.20 en video

51 TEMA 7.20 · MASAS SELARES, ADENOMAS HIPOFISIARIOS Y APOPLEJÍA HIPOFISARIA

ESQUEMA

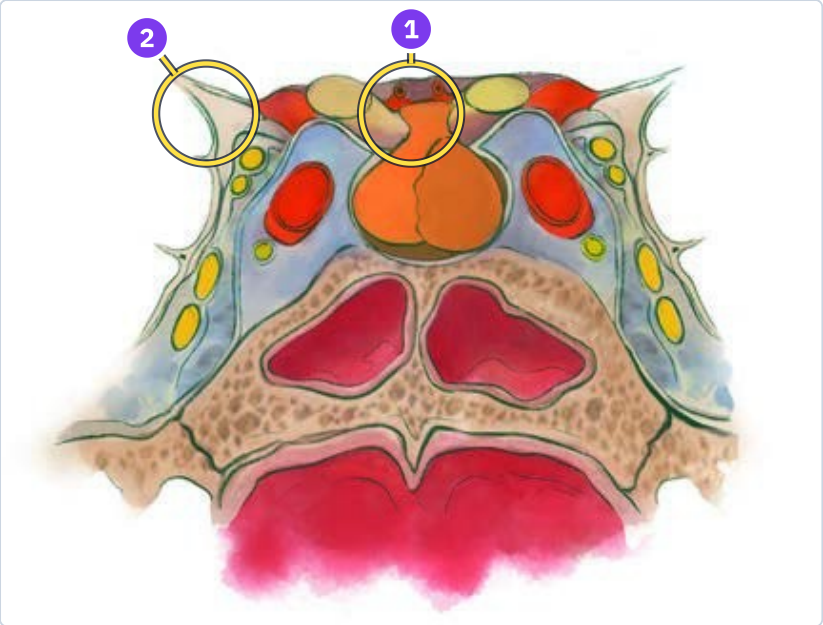


Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 40

QUÉ TIENES QUE VER

1. Hipófisis
2. Seno cavernoso

DIAGNÓSTICO

Anatomía de la región selar

La hipófisis rodeada por los senos cavernosos y sus nervios.

CONDUCTA INICIAL

Efecto de masa: hemianopsia bitemporal y pares III, IV y VI.

1.03.1.013 Tumores hipofisiarios — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.10.4.004 Campo visual — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Lesión del quiasma vs del nervio óptico.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P80 «Una mujer de 55 años consulta por cefalea progresiva, de localización interciliar y occipital, asociada a alteraciones visuales. Al examen…» → **En el quiasma óptimo**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 94
Tema 7.20

Clase 7.20 en video

52 TEMA 7.22 · ACROMEGALIA Y GIGANTISMO

FOTO CLÍNICA

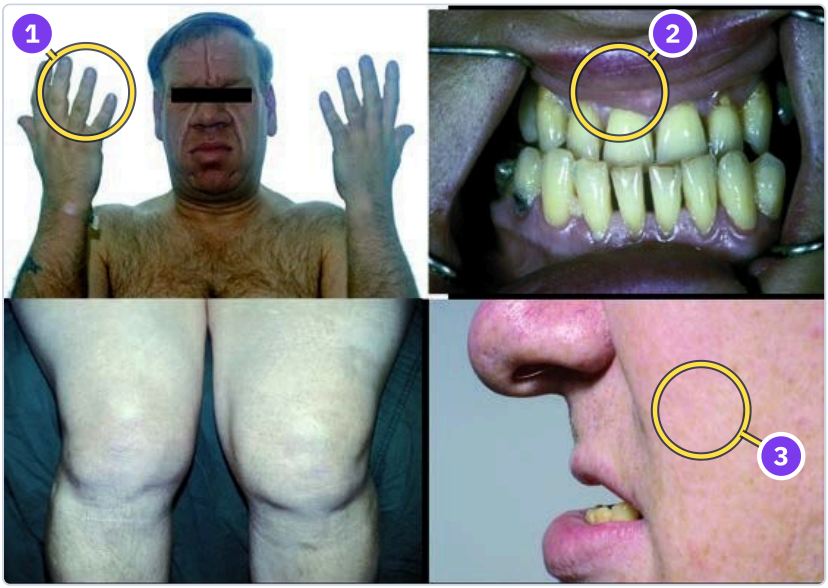


Imagen: Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 33

QUÉ TIENES QUE VER

1. Manos grandes
2. Diastema
3. Nariz y labios gruesos

DIAGNÓSTICO

Fenotipo acromegálico

Manos grandes, prognatismo, diastema y rasgos toscos.

CONDUCTA INICIAL

IGF-1 y luego GH tras sobrecarga de glucosa.

1.03.1.013 Tumores hipofisiarios — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipotiroidismo: también rasgos toscos.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P113 «Un paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula, con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, de la nariz…» → **Niveles de IGF-1**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 101
Tema 7.22

Clase 7.22 en video

53 TEMA 7.23 · HIPOPITUITARISMO, SÍNDROME DE SHEEHAN Y PANHIPOPITUITARISMO

IMAGEN RADIOLÓGICA

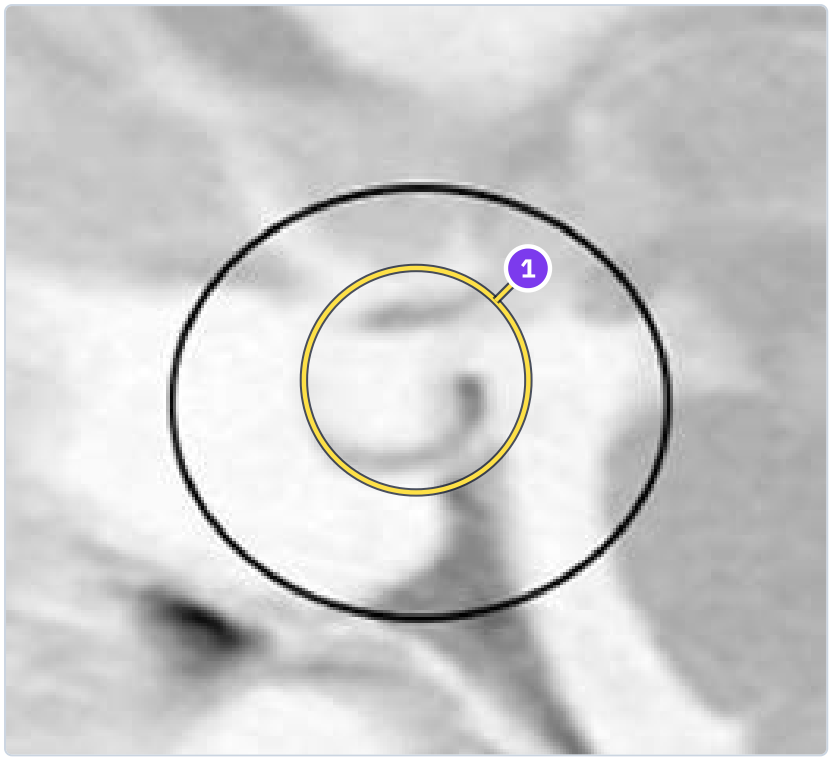


Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 645.5A

QUÉ TIENES QUE VER

1 Silla turca vacía

DIAGNÓSTICO

Silla turca vacía

Silla llena de LCR con la hipófisis aplanada (círculo).

CONDUCTA INICIAL

Evaluar hipopituitarismo; Sheehan tras hemorragia del parto.

1.03.1.014 **Hipopituitarismo**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Macroadenoma: masa que llena la silla.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P109 «Una paciente de 28 años, se realiza una histerectomía postparto, por una inercia uterina. Usted la atiende 6 meses después, sin lactancia y…» → **Panhipopituitarismo**

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 104
Tema 7.23

Clase 7.23 en video

54 TEMA 7.24 · DIABETES INSÍPIDA, SIADH Y NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN)

IMAGEN RADIOLÓGICA

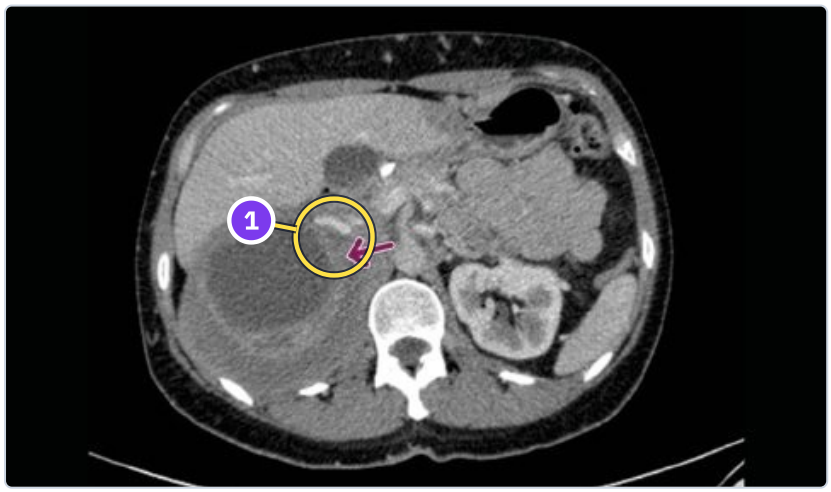


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 126

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa suprarrenal

DIAGNÓSTICO

MEN 2A: feocromocitoma

Masa suprarrenal derecha (flecha).

CONDUCTA INICIAL

MEN 2: buscar feocromocitoma antes de operar el cáncer medular.

1.03.1.009 **Hipertensión arterial de origen endocrino**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.03.1.023 **Tumor suprarrenal**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

MEN 1: paratiroides, páncreas, hipófisis.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO
p. 107
Tema 7.24

Clase 7.24 en video

55 TEMA 7.24 · DIABETES INSÍPIDA, SIADH Y NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN)

FOTO CLÍNICA

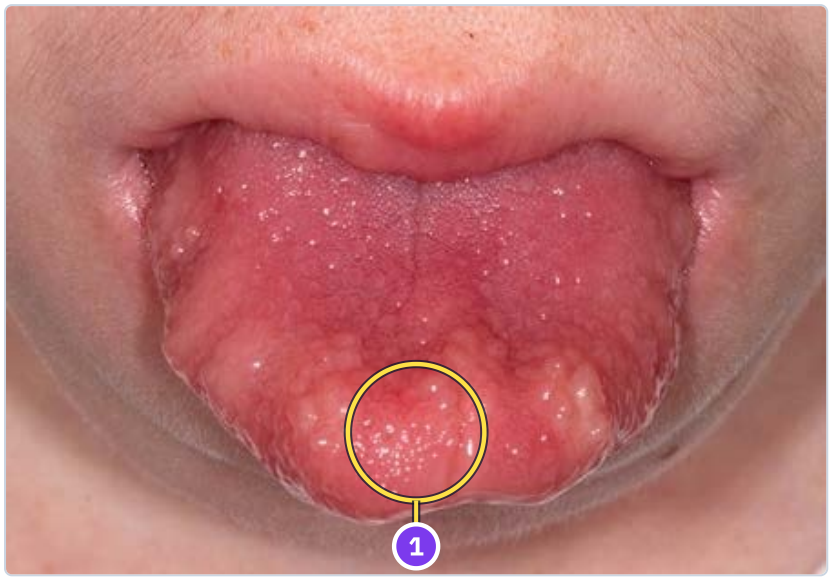


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4054

QUÉ TIENES QUE VER

1. Neuromas en la lengua

DIAGNÓSTICO

MEN 2B: neuromas mucosos

Nódulos en la lengua y labios gruesos.

CONDUCTA INICIAL

RET: tiroidectomía profiláctica precoz.

1.03.1.004 **Cáncer del tiroides**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Papilas linguales normales.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 107** Tema 7.24

Clase 7.24 en video

56 TEMA 7.25 · GINECOMASTIA

FOTO CLÍNICA

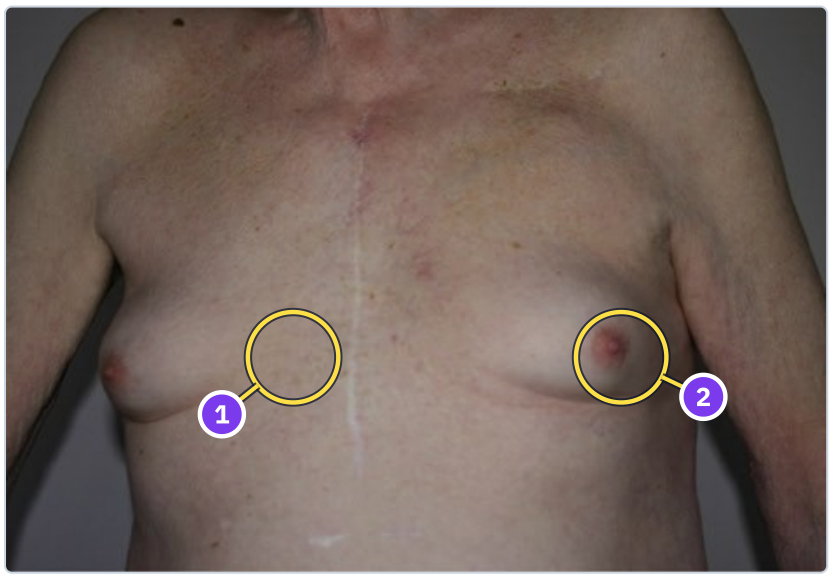


Imagen: Talley & O'Connor, Clinical Examination, Fig. 29.14

QUÉ TIENES QUE VER

1. Tejido mamario
2. Tejido mamario

DIAGNÓSTICO

Ginecomastia bilateral

Aumento del tejido mamario en el hombre.

CONDUCTA INICIAL

Puberal: tranquilizar; buscar fármacos; dura y unilateral: descartar cáncer.

1.03.1.023 **Ginecomastia**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Lipomastia: grasa sin tejido glandular.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P45** «Adolescente masculino de 14 años con aumento bilateral del tejido mamario subareolar, sensible al tacto, sin secreción. Sin medicamentos....» → **Ginecomastia puberal fisiológica; tranquiliza**...

TOMO ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO **p. 111** Tema 7.25

Clase 7.25 en video

Parecidas pero distintas

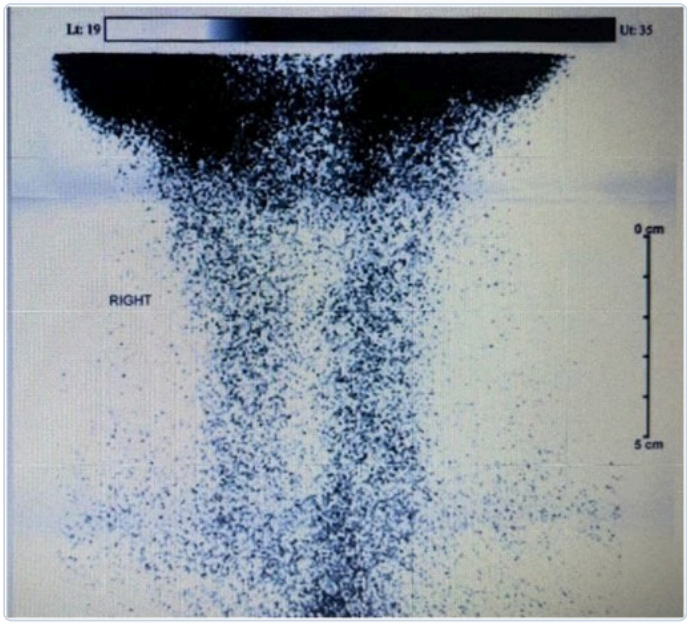
Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Graves vs tiroiditis



VS



A **Graves: captación difusa**

- Captación difusa aumentada

Ficha n.° 14 · p. 10

B **Tiroiditis: cintigrama en blanco**

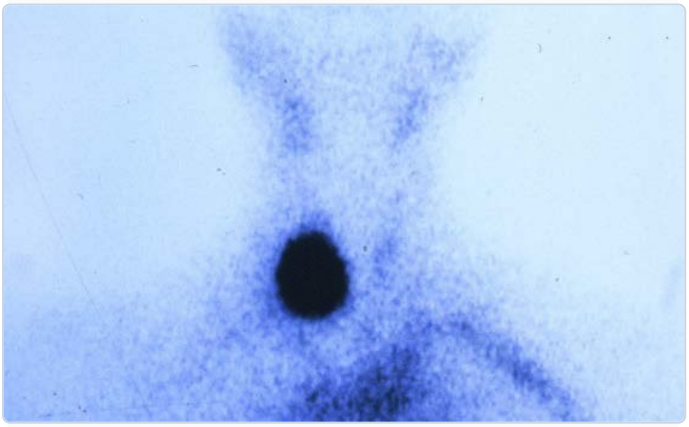
- Glándula en blanco

Ficha n.° 06 · p. 6

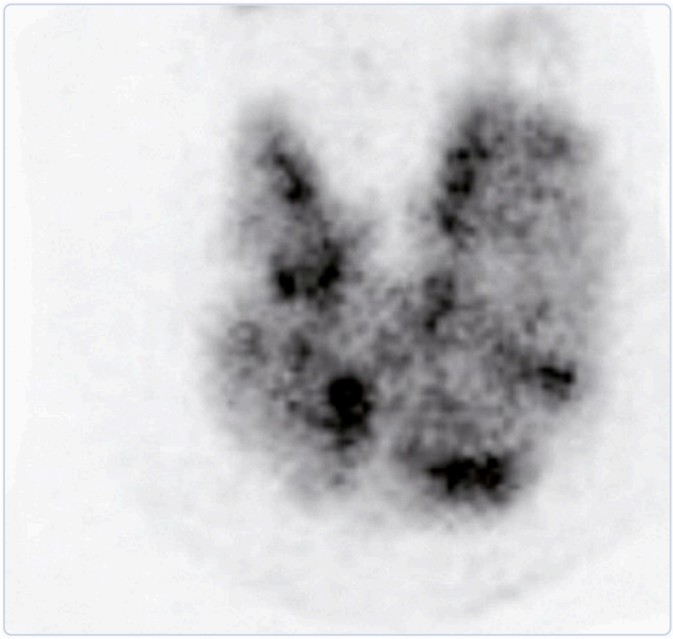
LA DIFERENCIA La tiroiditis no capta: no se dan antitiroideos.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Adenoma tóxico vs bocio multinodular tóxico



VS



A **Adenoma tóxico**

- Un nódulo caliente

Ficha n.° 15 · p. 11

B **Bocio multinodular tóxico**

- Zonas calientes y frías

Ficha n.° 16 · p. 11

LA DIFERENCIA Ninguno remite con fármacos: tratamiento definitivo.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hipotiroidismo congénito: antes y después



VS



A Hipotiroidismo congénito sin tratar

- Macroglosia, facies tosca

Ficha n.° 04 · p. 5

B El mismo niño con tratamiento

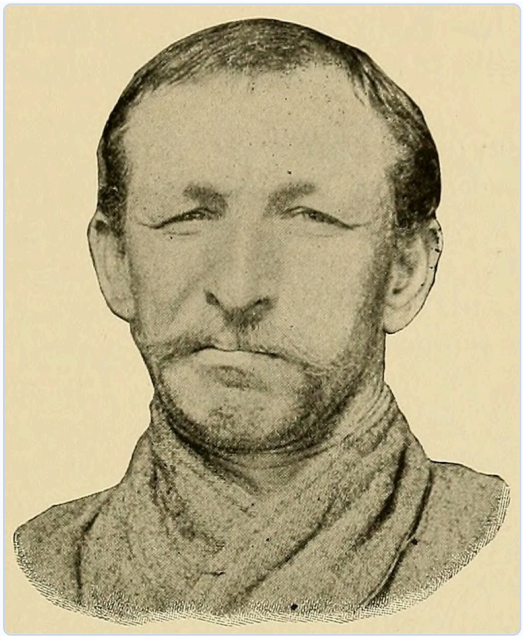
- Facies normal

Ficha n.° 05 · p. 6

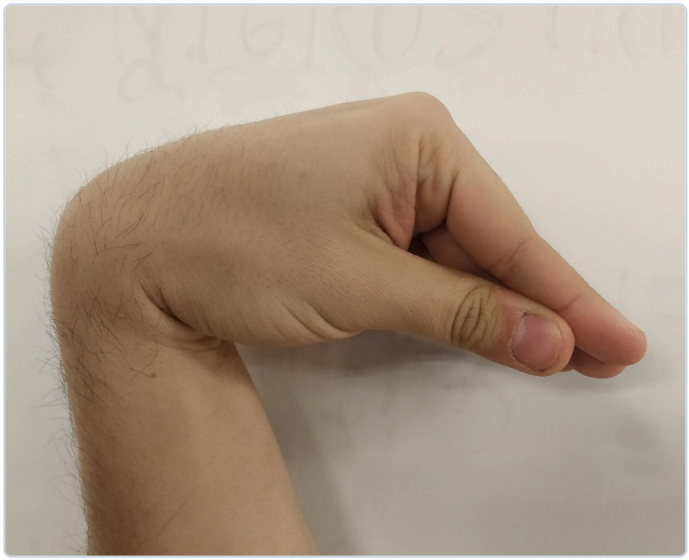
LA DIFERENCIA Los signos llegan tarde: por eso se tamiza.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Chvostek vs Trousseau



VS



A Signo de Chvostek

- Percutir el nervio facial

Ficha n.° 39 · p. 23

B Signo de Trousseau

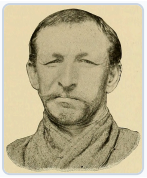
- Manguito sobre la sistólica

Ficha n.° 40 · p. 23

LA DIFERENCIA Trousseau es más específico.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.

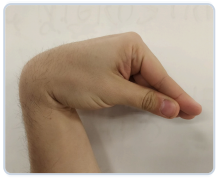


SIGNO DE CHVOSTEK

Contracción facial al percutir el nervio facial.

Se ve en: Hipocalcemia.

Tomo p. 79 · Atlas: ficha n.° 39, p. 23



SIGNO DE TROUSSEAU

Espasmo carpal al inflar el manguito.

Se ve en: Hipocalcemia.

Tomo p. 79 · Atlas: ficha n.° 40, p. 23



LÍNEA DE LOOSER-MILKMAN

Pseudofractura perpendicular a la cortical.

Se ve en: Osteomalacia.

Tomo p. 87 · Atlas: ficha n.° 48, p. 27



FACIES DE LUNA LLENA

Cara redonda y pletórica.

Se ve en: Síndrome de Cushing.

Tomo p. 52 · Atlas: ficha n.° 23, p. 15

Índice por tipo de imagen

22	1	5	22	1	5
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	TRAZADO (ECG / REGISTRO)	ECOGRAFÍA

Foto clínica · 22

02 Facies hipotiroidea (1.2) 4
03 Coma mixedematoso (1.3) 5
04 Hipotiroidismo congénito sin tratar (1.4) 5
05 El mismo niño con tratamiento (1.4) 6
10 Bocio difuso de Graves (7.6) 8
12 Orbitopatía tiroidea: retracción palpebral (7.6) 9
17 Bocio gigante compresivo (7.7) 12
21 Bocio multinodular (7.9) 14
23 Facies de luna llena (7.11) 15
25 Equimosis por fragilidad capilar (7.11) 16
27 Enfermedad de Addison: hiperpigmentación (7.12) 17
28 Addison: pliegues palmares (7.12) 17
29 Púrpura fulminante (Waterhouse-Friderichsen) (7.13) 18
30 Necrosis distal en la sepsis (7.13) 18
39 Signo de Chvostek (7.17) 23
40 Signo de Trousseau (7.17) 23
44 Osteonecrosis mandibular por bifosfonatos (7.18) 25
46 Rosario raquítico (7.19) 26
47 Muñecas ensanchadas en el raquitismo (7.19) 27
52 Fenotipo acromegálico (7.22) 29
55 MEN 2B: neuromas mucosos (7.24) 31
56 Ginecomastia bilateral (7.25) 31

Histología / citología · 1

22 Carcinoma papilar (7.10) 14

Esquema · 5

01 Clínica del hipotiroidismo (1.2) 4
24 Fenotipo cushingoide (7.11) 15
36 El QT y el calcio (7.16) 21
41 Densitometría: cómo leer el T-score (7.18) 24
51 Anatomía de la región selar (7.20) 29

Imagen radiológica · 22

06 Tiroiditis: cintigrama en blanco (1.5) 6
07 Patrones del cintigrama tiroideo (1.5) 7
13 Orbitopatía tiroidea en la TC coronal (7.6) 10
14 Graves: captación difusa (7.7) 10
15 Adenoma tóxico (7.7) 11
16 Bocio multinodular tóxico (7.7) 11
18 Gammagrafía: nódulo caliente (7.9) 12
26 TAC suprarrenal en el Cushing (7.11) 16
31 Adenoma suprarrenal en la RM (7.14) 19
32 Feocromocitoma en la RM (7.15) 19
33 Gammagrafía con MIBG (7.15) 20
34 Incidentaloma suprarrenal en la TAC (7.15) 20
35 Osteítis fibrosa quística (7.16) 21
38 Gammagrafía con sestamibi (7.16) 22
42 Fractura de Colles (7.18) 24
43 Fractura del cuello del fémur (7.18) 25
45 Fractura atípica subtrocantérea (7.18) 26
48 Línea de Looser-Milkman (7.19) 27
49 Macroadenoma hipofisario en la RM (7.20) 28
50 Craneofaringioma supraselar (7.20) 28
53 Silla turca vacía (7.23) 30
54 MEN 2A: feocromocitoma (7.24) 30

Trazado (ECG / registro) · 1

37 ECG de hipercalcemia (7.16) 22

Ecografía · 5

08 Ecografía de Hashimoto (1.5) 7
09 Tirotoxicosis por amiodarona tipo 1: Doppler hipervascular (1.5) 8
11 Eco Doppler de Graves (7.6) 9
19 Nódulo TI-RADS 5 (7.9) 13
20 Nódulo con criterios de malignidad (7.9) 13

Autoevaluación

6 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



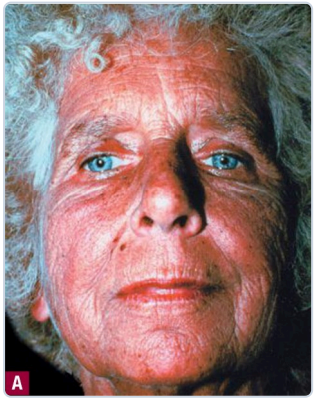
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



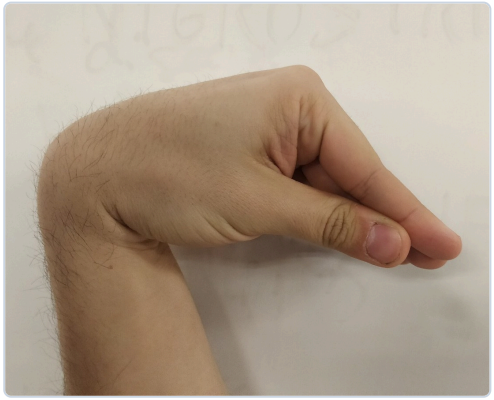
4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Facies hipotiroidea**	Edema periorbitario duro	02 · p. 4
2	**Coma mixedematoso**	Facies infiltrada, apática	03 · p. 5
3	**Orbitopatía tiroidea: retracción palpebral**	Retracción del párpado superior	12 · p. 9
4	**Facies de luna llena**	Cara redonda y pletórica	23 · p. 15
5	**Enfermedad de Addison: hiperpigmentación**	Hiperpigmentación facial	27 · p. 17
6	**Signo de Trousseau**	Mano en comadrón	40 · p. 23